

Élaboration de plans nationaux de lutte contre la méningite

Manuel opérationnel



Organisation
mondiale de la Santé

Élaboration de plans nationaux de lutte contre la méningite

Manuel opérationnel



**Organisation
mondiale de la Santé**

Élaboration de plans nationaux de lutte contre la méningite : manuel opérationnel [Developing national meningitis plans: an operational manual]

ISBN 978-92-4-011460-9 (version électronique)

ISBN 978-92-4-011461-6 (version imprimée)

© **Organisation mondiale de la Santé 2025**

Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr>).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'œuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation du logo de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (<https://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules/index.html>).

Citation suggérée. Élaboration de plans nationaux de lutte contre la méningite : manuel opérationnel [Developing national meningitis plans: an operational manual]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2025. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse <https://iris.who.int/?locale-attribute=fr&>.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir <https://www.who.int/publications/book-orders>. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir <https://www.who.int/fr/copyright>.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'OMS a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue pour responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Design and layout: Rooftop, Gqeberha, South Africa.

Table des matieres

Remerciements	v
Sigles et acronymes	vi
1. Introduction	1
1.1 La feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030	1
1.2 Les plans nationaux pour vaincre la méningite	2
2. Élaboration des plans nationaux : marche à suivre et principes essentiels	4
2.1 Une démarche nationale	4
2.2 Les étapes d'élaboration du plan	5
2.3 Élargir le raisonnement, au-delà de la méningite !	6
2.4 S'appuyer sur l'existant	7
2.5 Comment utiliser ce manuel ?	7
3. Phase préparatoire	8
3.1 Vue d'ensemble	8
3.2 Analyse épidémiologique	8
3.3 Recensement des activités	9
3.4 Analyse des parties prenantes	9
3.5 Évaluation des ressources disponibles	9
3.6 Plan d'atténuation des risques et d'intervention	10
4. Phase de planification des activités	12
4.1 Prévention et lutte contre les épidémies (pilier 1)	13
Objectifs	13
Domaines d'intervention	13
Activités	14

4.2 Diagnostic et traitement (pilier 2)	21
Objectifs	21
Domaines d'intervention	21
Activités	22
4.3 Surveillance des maladies (pilier 3)	28
Objectifs	28
Domaines d'intervention	28
Activités	29
4.4 Soutien et soins (pilier 4)	32
Objectifs	32
Domaines d'intervention	32
Activités	33
4.5 Sensibilisation et mobilisation (pilier 5)	39
Objectifs	39
Domaines d'intervention	39
Activités	40
5. Mécanismes de déploiement	44
5.1 Leadership, coordination et synergies	44
5.2 Budgétisation et financement	45
5.3 Logistique et chaîne d'approvisionnement	46
5.4 Suivi et évaluation	47
Annexe 1 : Les parties prenantes	50
Annexe 2a : Vue d'ensemble d'une proposition de modèle (prêt à l'emploi) – exemple du pilier 2	52
Annexe 2b : Exemple – matrice de suivi de la mise en œuvre d'une activité	53
Annexe 3 : Documentation	54

Remerciements

Le présent manuel s'inspire de la feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030, approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA73.9). Les principales étapes et activités exposées dans la feuille de route qui sont applicables à l'échelle nationale ont été converties en propositions d'activités à intégrer dans les plans nationaux.

Le manuel a été élaboré selon un processus itératif par le secrétariat principal de la feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030, au siège de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ont ainsi participé à l'élaboration du manuel : des collègues de l'OMS provenant du Département Vaccination, vaccins et produits biologiques de la Division Couverture sanitaire universelle/Parcours de vie, l'unité Épidémies à fort impact du programme des urgences sanitaires et l'équipe Santé cérébrale de la division Maladies transmissibles et non transmissibles.

Des versions préliminaires de ce manuel ont été testées par des pays de la Région africaine au cours de deux ateliers, en novembre 2022 et juin 2023. Les commentaires fournis se sont avérés extrêmement utiles pour en améliorer le contenu. Nous remercions chaleureusement les spécialistes des bureaux nationaux et régionaux de l'OMS, ainsi que les spécialistes et partenaires externes qui ont apporté leur contribution et effectué un examen critique. Cela inclut des membres du Groupe technique spécial pour vaincre la méningite à l'horizon 2030.

Sigles et acronymes

CoMO	Confederation of Meningitis Organizations	Spn	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
CSU	couverture sanitaire universelle	SIMR	surveillance intégrée de la maladie et la riposte
DHIS2	Système d'information sanitaire de district (version 2) (OMS)	SSP	soins de santé primaires
EWARS	système de signalement précoce, d'alerte et de riposte (OMS)	TDR	test de diagnostic rapide
GIC	Groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins	Vaccination 2030	Programme pour la vaccination à l'horizon 2030
Hib	<i>Haemophilus influenzae de type b</i>	VPC	vaccin antipneumococcique conjugué
LCR	liquide céphalorachidien		
MenACV	vaccin conjugué contre le méningocoque A		
GTCV	groupe consultatif technique national sur la vaccination		
Nm	<i>Neisseria meningitidis</i>		
NmA	<i>Neisseria meningitidis</i> du sérogroupe A		
OMS	Organisation mondiale de la Santé		
ONG	organisation non gouvernementale		
PEV	Programme élargi de vaccination		
S&E	suivi et évaluation		
SGB	streptocoques du groupe B		
SNV	Stratégie nationale de vaccination		
SORMAS	Surveillance Outbreak Response Management & Analysis System		

1. Introduction

1.1 La feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030

La méningite est une maladie débilitante, potentiellement mortelle, qui est susceptible de toucher des personnes de tous les âges dans le monde entier. Ses conséquences ne se limitent pas aux seuls individus atteints, mais affectent également les personnes qui s'occupent d'eux, leur famille et des communautés entières, avec de sérieuses retombées sanitaires, économiques et sociales.

- La méningite bactérienne représente l'une des formes les plus meurtrières et invalidantes de la maladie. Elle peut occasionner le décès en moins de 24 heures, et un cinquième des personnes ayant survécu à l'épisode aigu restent handicapées à vie (notamment surdité, épilepsie, déficits neurologiques focaux, troubles cognitifs et amputation de membres).
- Bien que 80 % des cas dans le monde soient spontanés et ne soient associés à aucune flambée épidémique, les épidémies de méningite bactérienne peuvent rendre les communautés vulnérables et perturber sérieusement les systèmes de santé.
- La vaccination pourrait éviter de nombreux cas de méningite bactérienne et décès liés à cette maladie. Les progrès accomplis dans la lutte contre la méningite restent néanmoins en deçà de ceux réalisés pour les autres maladies évitables par la vaccination.

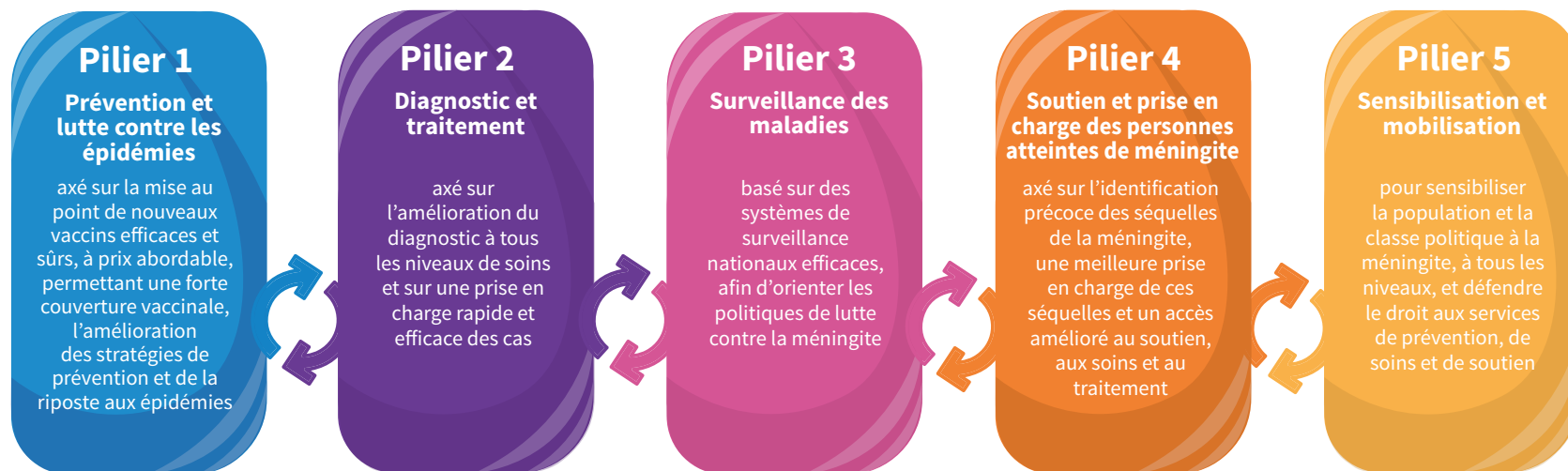
La feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030 a été adoptée par tous les États Membres de l'OMS lors de la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa toute première résolution sur la lutte contre la méningite. Il s'agit d'un engagement ferme de la part de tous les pays à faire reculer le fardeau de la méningite.

La feuille de route présente une stratégie détaillée pour s'attaquer aux principales causes de la méningite bactérienne au moyen de trois objectifs visionnaires :

- éliminer les épidémies de méningite bactérienne ;
- réduire le nombre de cas imputables à la méningite bactérienne à prévention vaccinale de 50 % et le nombre de décès de 70 % ;
- réduire le handicap et améliorer la qualité de vie à la suite d'une méningite, toutes causes confondues.

Pour atteindre ces objectifs, la feuille de route a identifié diverses activités réparties dans cinq piliers interconnectés, comme l'illustre la Figure 1.

Figure 1 Les cinq piliers pour vaincre la méningite



En abordant ces piliers à travers une méthode coordonnée et intégrée, des progrès notables pourront être accomplis en vue de vaincre la méningite et de réduire ses conséquences sur les personnes et les communautés du monde entier.

1.2 Les plans nationaux pour vaincre la méningite

Vaincre la méningite ne sera possible que par la mobilisation des régions et des pays, qui devront prendre les mesures nécessaires. Tous les États Membres se sont engagés à élaborer et à mettre en œuvre des plans de lutte contre la méningite nationaux et pluridisciplinaires qui soient équitables, inscrits dans la durée, pleinement intégrés dans les systèmes de santé et fortement interconnectés avec les autres initiatives pertinentes (Encadré 1). Les plans nationaux doivent être adaptés au contexte local, pluriannuels et faire l'objet d'un suivi, d'évaluations et de mises à jour à intervalles réguliers.

Le processus d'élaboration de plans nationaux concourt à la réalisation de deux objectifs principaux :

- **identifier et énoncer les objectifs, activités et jalons** de la lutte contre la méningite, en précisant les échéances, budgets et organismes/personnels responsables associés ;
- **faire participer les parties intéressées à tous les niveaux** à l'élaboration du plan pour rendre plus aisée sa mise en œuvre ultérieure.

Le présent manuel a pour objectif de fournir des orientations afin d'aider les pays dans l'élaboration de leurs plans nationaux pour vaincre la méningite. Il vise à faciliter une méthode de travail qui favorisera un engagement ferme et une forte adoption des plans.

Encadré 1. Engagements des pays envers un monde sans méningite (résolution WHA73.9)

Durant la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé, tous les États Membres ont exprimé leur engagement :

- (1) selon le contexte national, **à faire de la méningite une priorité politique en l'intégrant aux politiques et aux plans nationaux, soit comme plan autonome, soit dans le cadre d'initiatives de santé plus larges ;**
- (2) **à fixer des cibles nationales et à élaborer et à mettre en œuvre, dans le contexte des priorités nationales et au travers d'un plan intégré de lutte contre la méningite, des mesures de prévention et de lutte pluridisciplinaires, précises et efficaces par rapport à leur coût, ainsi qu'une offre de services, y compris un accès équitable à des vaccins sûrs, efficaces, de bonne qualité et économiquement abordables, des traitements, des mesures prophylactiques, des interventions de lutte ciblées, des produits de diagnostic, des soins de santé appropriés, notamment des soins de réadaptation, et des modèles de financement durable adaptés aux schémas de transmission locaux pour la lutte à long terme et l'élimination des épidémies ;**
- (3) **à veiller à ce que les politiques et les plans nationaux concernant la prévention et la prise en charge de la méningite couvrent toutes les zones où le risque de transmission est élevé ;**
- (4) **en partenariat avec d'autres groupes concernés par les soins aux personnes handicapées, à mettre sur pied et à renforcer les services visant à réduire la charge que constituent les séquelles** pour les personnes qui ont contracté la méningite par le passé et qui sont désormais en situation de handicap ;
- (5) **à mettre en place, selon le contexte et les priorités au niveau national, des mécanismes nationaux intégrés et pluridisciplinaires de prévention et de surveillance de la méningite pour coordonner la mise en œuvre du plan de lutte contre la méningite,** et dans lesquels soient représentés différents ministères, organismes, partenaires, organisations de la société civile et communautés participant aux efforts de lutte contre la méningite et aux services de réadaptation ;
- (6) **aux fins de réduire les répercussions sur la santé publique et les effets socioéconomiques de la méningite, à renforcer la capacité nationale** de préparation conformément au Règlement sanitaire international (2005), **de dépistage et de traitement précoces, de confirmation au laboratoire, de prise en charge des cas et de riposte immédiate et efficace aux flambées de méningite ;**
- (7) **à renforcer la surveillance et la notification précoce de la méningite** par les systèmes de surveillance nationaux, conformément au Règlement sanitaire international (2005) et aux priorités nationales, et à renforcer les capacités de collecte et d'analyse de données, y compris au sujet des séquelles ;
- (8) **à renforcer la participation communautaire, la communication et la mobilisation sociale en ce qui concerne la prévention de la méningite, le dépistage précoce, la propension à se faire soigner, la réadaptation** et d'autres activités connexes ;
- (9) **à soutenir, notamment par la coopération internationale, la recherche et l'innovation visant à améliorer la prévention et la lutte contre la méningite,** y compris moyennant une amélioration des vaccins et des stratégies de vaccination ; de meilleurs produits de diagnostic rapide, traitements et médicaments ; le repérage et la prise en charge des séquelles ; et la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ;
- (10) **à envisager la mise en œuvre des points susmentionnés à la lumière du contexte national général et de l'objectif du renforcement des systèmes de santé et de la couverture sanitaire universelle.**

2. Élaboration des plans nationaux : marche à suivre et principes essentiels

Comment élaborer les plans nationaux pour vaincre la méningite ?

2.1 Une démarche nationale

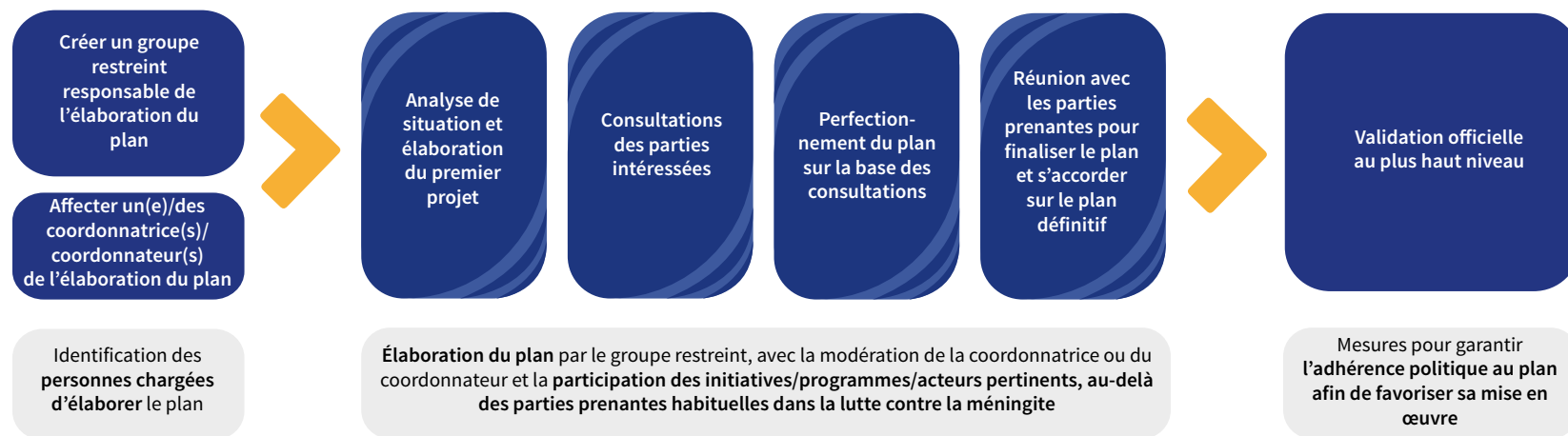
Il appartient à chaque pays de déterminer la marche à suivre pour élaborer son plan national de lutte contre la méningite. Cependant, les trois points suivants peuvent être pris en compte tout en pouvant se traduire de différentes manières en fonction des facteurs contextuels, des méthodes opérationnelles, ainsi que du temps consacré et des ressources allouées à l'élaboration du plan.

- Veiller à ce que **tous les acteurs concernés participent – à un moment donné – au processus**. La mobilisation de toutes les parties prenantes est essentielle pour garantir que le plan tienne compte de différents points de vue et cela facilitera sa mise en œuvre. Si certains acteurs peuvent jouer un rôle de premier plan tout au long du processus, d'autres peuvent ne participer ou n'être consultés qu'à des étapes précises.
 - Au sein du Ministère de la santé, des membres des services de surveillance et de statistiques sanitaires, du programme de vaccination national, des laboratoires, des soins de santé primaires (SSP) et de la planification et du financement doivent tous jouer un rôle central.
 - D'autres représentantes et représentants du secteur de la santé pouvant inclure des spécialistes nationaux et des personnels de santé travaillant dans le domaine des maladies infectieuses, de la neurologie, des soins périnataux et de la réadaptation, et des membres des initiatives et programmes interconnectés.

- Des agentes et agents de santé communautaires, des organisations de la société civile et des groupes de patientes et patients doivent également intervenir pour garantir que le plan prend en compte les besoins et les problèmes des communautés qu'il a pour ambition de servir.
- Des acteurs de secteurs autres que celui de la santé peuvent également apporter un concours substantiel au plan et contribuer à son succès (par exemple, le Ministère de l'éducation peut jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre d'interventions en milieu scolaire, notamment par l'identification des enfants présentant des séquelles et par l'éducation pour la santé).
- Nommer une personne qui sera **chargée de coordonner l'élaboration du plan**.
 - Compte tenu de la nature pluridisciplinaire de la feuille de route et des divers domaines qu'elle couvre, l'aptitude de la coordonnatrice ou du coordonnateur à établir des liens et à identifier les acteurs, programmes, initiatives et organismes pertinents sera cruciale.
 - La coordonnatrice ou le coordonnateur doit avoir une bonne compréhension de la méningite, notamment de son épidémiologie, des stratégies de prévention, des solutions de diagnostic et de traitement et des séquelles à long terme.
 - Si nécessaire, un binôme, plutôt qu'une seule personne, peut partager les responsabilités de coordination.
- S'assurer que le **plus haut niveau de prise de décision participe activement au processus et adopte le plan**. L'adhésion politique est déterminante pour la mise en œuvre effective du plan.

La Figure 2 propose un cadre qui peut être adapté au contexte national.

Figure 2 Élaboration du plan et adhésion politique



2.2 Les étapes d'élaboration du plan

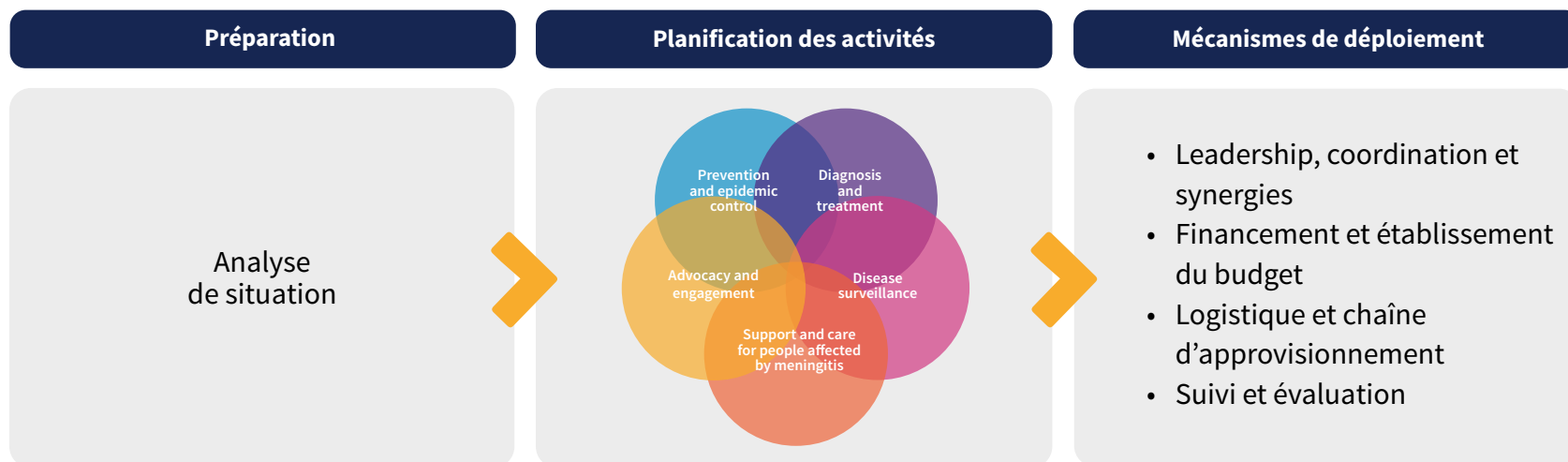
L'élaboration d'un plan national de lutte contre la méningite peut être divisée en trois étapes (Figure 3).

- **Préparation.** *Quelle est la situation actuelle en matière de lutte contre la méningite ?* La phase préparatoire a pour objectif d'évaluer la situation actuelle et d'établir une compréhension commune du point de départ, notamment des défis à relever. Cette analyse de situation consiste à évaluer le fardeau de la méningite au niveau national, à recenser les interventions et activités existantes de lutte contre la méningite, à identifier les parties intéressées et à évaluer les ressources humaines et financières disponibles.
- **Planification des activités.** *Quels sont les objectifs et quelles activités faut-il entreprendre ?* La phase de planification des activités consiste à définir les objectifs et les activités pour chacun des piliers de la feuille de route en s'appuyant sur les résultats de l'analyse de situation. Bien que la feuille de route mondiale et le présent document fournissent un cadre avec des propositions

d'objectifs de haut niveau, de domaines d'intervention et d'activités, ceux-ci doivent être adaptés aux besoins, situations et priorités propres à chaque contexte particulier

- **Définition des mécanismes de déploiement.** *Comment mettre en œuvre efficacement les activités du plan national ?* Cette étape s'emploie essentiellement à établir des mécanismes permettant de mettre en œuvre de manière efficace les activités définies pour tous les piliers de la feuille de route. Ces mécanismes incluent la création de structures d'encadrement et de coordination efficaces qui doivent également mettre à profit les situations propices à la synergie et à l'intégration, l'élaboration de budgets et de stratégies de financement adaptés, la sécurisation de mécanismes de logistique et de chaîne d'approvisionnement efficaces, ainsi que la conception et la mise en œuvre de processus de suivi et d'évaluation ciblés.

Figure 3 Les étapes d'élaboration du plan



2.3 Élargir le raisonnement, au-delà de la méningite !

La feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030 a des implications directes sur les SSP et la couverture sanitaire universelle (CSU). Elle établit des liens avec des domaines tels que la lutte contre le sepsis, la pneumonie et l'infection à VIH, et vient compléter les efforts visant à renforcer les systèmes de santé, à contrer la résistance aux antimicrobiens et à enrichir les informations sanitaires.

Compte tenu de la nature pluridisciplinaire de la feuille de route, une approche polyvalente et étendue est essentielle pour mettre au point les activités et définir les mécanismes de déploiement. Cela favorisera l'établissement de liens avec d'autres activités et initiatives, créant ainsi des situations propices à la réalisation d'objectifs complémentaires et à la participation d'acteurs autres que les parties prenantes habituelles de la méningite. Pendant l'élaboration du plan :

1. **Identifier les synergies avec d'autres initiatives et programmes pour établir des liens solides.** Les activités de lutte contre la méningite ne doivent pas être réalisées indépendamment des autres activités et initiatives ou en concurrence

avec elles. Elles doivent alignées et coordonnées avec les objectifs de santé publique plus larges et les efforts visant à renforcer les systèmes de santé.

- Qu'est-ce que le plan de lutte contre la méningite peut apporter à d'autres initiatives/programmes ? Comment ceux-ci peuvent-ils contribuer au plan de lutte contre la méningite ?
 - Comment contribuer mutuellement à la réalisation des objectifs ? Comment partager au mieux les connaissances, l'expertise et les ressources techniques et financières ?
2. **Insister sur l'intégration dans les SSP** et étudier comment le plan de lutte contre la méningite peut renforcer ces soins et contribuer à atteindre la CSU, en particulier en intégrant la méningite dans les ensembles des prestations nationaux de la CSU.
 3. **Tenir compte des parties prenantes qui ne participaient pas jusqu'à présent aux efforts de lutte contre la méningite**, mais qui peuvent jouer un rôle important dans l'éradication de cette maladie. Ceci inclut des organismes n'appartenant pas au secteur de la santé. L'annexe 1 fournit la liste des parties prenantes susceptibles de favoriser la mise en œuvre du plan d'action et d'amplifier son impact.

2.4 S'appuyer sur l'existant

1. **Des stratégies, objectifs et activités visant à vaincre la méningite ont été identifiés** au niveau mondial, et souvent au niveau régional. **Ils doivent être adaptés aux priorités et au contexte particuliers du pays**, afin de faciliter l'élaboration d'un plan national. Les principaux documents fondamentaux comprennent :
 - la feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030 ;
 - le plan régional ou le cadre régional de mise en œuvre pour vaincre la méningite (selon le cas).
2. En outre, comme le souligne le présent document et l'énonce la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé (Encadré 1), il est essentiel que le **plan national soit en phase et coordonné avec les autres activités et objectifs nationaux**. Ainsi :
 - le plan doit s'inspirer des autres plans nationaux, en particulier ceux qui s'intéressent à des sujets en rapport avec la lutte contre la méningite, notamment, mais non exclusivement, la vaccination, les SSP, le bon usage des antimicrobiens, la déficience auditive et la santé cérébrale ;
 - les lignes directrices, stratégies et documents nationaux existants en rapport avec la lutte contre la méningite et des sujets connexes, même s'ils doivent être actualisés ou complétés, sont des sources d'information précieuses à exploiter.
3. Enfin, **la collaboration avec d'autres pays est encouragée afin de partager les projets et les idées qui émergent pendant l'élaboration de ces plans**. Si nécessaire, les bureaux régionaux de l'OMS peuvent promouvoir l'échange d'informations et de meilleures pratiques.

2.5 Comment utiliser ce manuel ?

Ce manuel a été conçu pour faciliter l'élaboration du plan.

1. Pour chaque pilier, le manuel **propose des objectifs, des domaines d'intervention et des activités**. En outre, pour chaque domaine d'intervention, **des possibilités d'affinage des activités** sont présentées afin de mieux les adapter au contexte. Tous les objectifs, domaines d'intervention ou activités peuvent ne pas être applicables ou pertinents dans un pays donné, et d'autres peuvent être manquants et devront alors être ajoutés. Des adaptations en fonction du contexte seront nécessaires.
2. Un **modèle** (présenté dans l'annexe 2a et téléchargeable au format Microsoft Word) est fourni avec le document. Ce modèle reprend les piliers et domaines d'intervention proposés dans le présent manuel. Il **peut être complété avec des objectifs, des domaines d'intervention, des activités, des mesures spécifiques**, des responsabilités et des échéances au niveau national. S'il y a lieu, le modèle peut être adapté et d'autres champs peuvent être ajoutés (par exemple, ressources/budget, sources de financement, grandes étapes, indicateurs). Il est également possible d'ajuster, de supprimer ou d'ajouter des domaines d'intervention. Ce tableau peut en outre servir de base au suivi de la mise en œuvre des activités (voir la section *Suivi et évaluation*).
3. L'annexe 3 répertorie, pour chacun des piliers, des documents de référence qui fournissent d'autres orientations techniques spécifiques. Cette liste est non exhaustive et de nouveaux documents viendront compléter ou remplacer les documents actuellement présentés. Les documents de référence régionaux ou nationaux supplémentaires doivent également être pris en compte.

3. Phase préparatoire

Quelle est la situation actuelle en matière de lutte contre la méningite ?

3.1 Vue d'ensemble

La phase préparatoire du plan national de lutte contre la méningite consiste à réaliser une **analyse de situation** détaillée et à identifier les lacunes spécifiques au contexte lors de la mise en œuvre des interventions de lutte contre la méningite. L'analyse de situation doit être réalisée avant de commencer les étapes de planification des activités et doit inclure les tâches suivantes :

- **Analyse épidémiologique.** Une analyse épidémiologique préliminaire est une étape essentielle pour évaluer le fardeau de la méningite aux niveaux national et infranational et pour identifier les populations ou les zones les plus à risque.
- **Recensement des activités.** Les activités existantes de lutte contre la méningite doivent être recensées pour les cinq piliers de la feuille de route.
- **Analyse des parties prenantes.** Toutes les parties prenantes participant (ou qui pourraient contribuer) à la lutte contre la méningite aux niveaux local, national et international doivent être identifiées et recensées. Celles-ci peuvent inclure i) les parties prenantes participant actuellement à la lutte contre la méningite et ii) des parties prenantes supplémentaires susceptibles de jouer un rôle plus important à l'avenir (voir l'annexe 1).
- **Évaluation des ressources disponibles.** Les ressources humaines, financières et infrastructurelles disponibles doivent être évaluées et mobilisées pour soutenir la mise en œuvre du plan, tout en tenant compte des synergies avec d'autres interventions de santé publique et de l'intégration dans d'autres domaines d'activité.

Chacune de ces activités peut être réalisée par étapes afin d'évaluer l'état actuel de la lutte contre la méningite dans le contexte pertinent et d'identifier les freins et les

obstacles qui éclaireront la phase suivante de la planification des activités. Il est possible de travailler simultanément sur divers éléments et la pertinence de chaque étape peut varier en fonction du contexte.

3.2 Analyse épidémiologique

Une analyse épidémiologique est essentielle pour estimer le fardeau de la méningite aux niveaux national et infranational. Les sources d'information exploitables à ces fins incluent les données de laboratoire et de surveillance, les données d'admission en établissement de santé et/ou à l'hôpital et les certificats de décès (lorsqu'ils sont disponibles). Certaines informations peuvent provenir des établissements d'enseignement ou des instituts de recherche. L'analyse épidémiologique doit notamment se pencher sur les éléments suivants :

- **Épidémiologie descriptive.** L'épidémiologie descriptive consiste à analyser les caractéristiques de base des cas de méningite et des décès liés à cette maladie pour identifier les populations les plus touchées. Si la granularité des données le permet, cette analyse doit également être stratifiée sur l'agent pathogène responsable, l'âge, le genre, la situation géographique et l'heure de survenue.
- **Analyse de l'évolution dans le temps.** L'analyse de l'évolution dans le temps consiste à examiner les modifications de l'incidence de la méningite au fil du temps. Cette analyse contribue à la détection de profils saisonniers et cycliques d'apparition de la maladie et à capturer l'évolution de son épidémiologie au fil du temps.
- **Analyse spatiale.** L'analyse spatiale consiste à examiner la répartition géographique des cas de méningite et des décès liés à cette maladie et à identifier les zones les plus exposées. À ces fins, le niveau du district doit être l'unité d'analyse minimale, même si une analyse plus fine des données permettrait une compréhension plus détaillée de l'épidémiologie pour orienter des mesures de lutte ciblées.

- **Analyse des facteurs de risque.** L'analyse des facteurs de risque vise à identifier les facteurs associés à un risque élevé de méningite, notamment l'âge, le genre, les maladies sous-jacentes, l'immunodépression, la malnutrition et l'exposition à certaines conditions (par exemple, surpopulation dans les camps de réfugiés).
- **Couverture vaccinale.** Les toutes dernières données sur la couverture vaccinale (programmes de vaccination systématique et campagnes de vaccination) contre divers agents pathogènes responsables de la méningite permettent de mieux cerner les domaines potentiels d'intervention et, couplées aux données sur le fardeau de la méningite, peuvent éclairer les stratégies de détermination des priorités.
- **Flambées épidémiques précédentes.** La survenue et l'ampleur des épidémies de méningite au cours des 5 à 10 dernières années, ainsi que la mortalité associée, doivent être examinées. Il conviendra en outre de compiler les données existantes sur les cas et les décès par âge, genre et zone géographique.

Les résultats de l'analyse sont à interpréter en tenant compte des sources de données disponibles et des limites. L'interprétation doit également tenir compte des résultats comparatifs par rapport à d'autres pays ou régions et de l'évolution dans le temps. Les résultats épidémiologiques pourront à terme être utilisés pour éclairer l'élaboration d'interventions de lutte ciblées. En outre, des insuffisances dans les mécanismes de notification et/ou dans la confirmation en laboratoire pourraient être identifiées pendant le recueil des données de surveillance.

3.3 Recensement des activités

L'évaluation des activités existantes de lutte contre la méningite au niveau national est une étape cruciale dans l'identification des éléments à améliorer et dans l'élaboration d'un plan de lutte contre la méningite. L'évaluation de chaque pilier de la feuille de route est essentielle pour garantir qu'aucun élément critique n'a été négligé. La section *Planification des activités* fournit des indications sur les activités à envisager. L'examen détaillé du travail existant et son inventaire peuvent aider à identifier des obstacles potentiels ou des étapes du processus que le plan pourrait contribuer à régler de manière adéquate.

3.4 Analyse des parties prenantes

L'identification et la mobilisation des parties intéressées par la lutte contre la méningite, ainsi que par le renforcement des systèmes de santé, peut être particulièrement avantageux pour les gouvernements : meilleure compréhension de la situation du pays, montée en puissance des interventions préventives, amélioration du diagnostic, du traitement, des soins et de la réadaptation, augmentation des efforts de mobilisation et de sensibilisation de la communauté, identification d'approches innovantes ainsi que transparence et respect assurés du principe de responsabilité dans l'exécution et l'évaluation des plans nationaux.

Les parties prenantes incluent des individus, des groupes ou des organismes qui ont un intérêt direct dans les activités et résultats en rapport avec la lutte contre la méningite et ceux qui peuvent être affectés par ces activités et résultats. Une opération de recensement complet des parties prenantes doit être réalisée pour tous les piliers de la feuille de route afin d'assurer l'identification minutieuse de toutes les parties intéressées. Il est également important d'identifier les domaines auxquels les parties prenantes n'ont encore jamais participé, mais pour lesquels elles pourraient se mobiliser dans le cadre des plans nationaux.

Une liste de parties prenantes et de leurs rôles possibles dans l'élaboration des plans nationaux de lutte contre la méningite est fournie dans l'annexe 1.

3.5 Évaluation des ressources disponibles

L'évaluation des ressources disponibles est une étape cruciale dans la phase préparatoire d'un plan national de lutte contre la méningite. Les principaux domaines à évaluer et mobiliser initialement pour appuyer la mise en œuvre du plan sont les suivants :

- **Ressources humaines.** Il convient d'évaluer la disponibilité des personnels de santé, agentes et agents de santé communautaires, professionnelles et professionnels de santé publique et autres personnels pertinents et leur capacité à fournir des services de prévention, de diagnostic, de traitement, de surveillance de la méningite et de soins post-hospitalisation. En cas de pénurie de personnel, des activités de formation et de renforcement des capacités peuvent être nécessaires.

- **Ressources financières.** Les coûts de mise en œuvre du plan de lutte contre la méningite doivent être estimés, sans omettre le coût des vaccins, des médicaments, des produits de diagnostic et d'autres fournitures médicales. Les sources de financement doivent être identifiées, qu'elles soient nationales ou internationales, et des mécanismes doivent être mis en place pour assurer que ce financement est disponible et correctement utilisé.
- **Ressources infrastructurelles.** Il convient d'évaluer la disponibilité des établissements de santé, parmi lesquels les laboratoires, et leur capacité à offrir des services de prévention, diagnostic, traitement et surveillance de la méningite. Dans les milieux dont les ressources sont limitées, on pourra envisager d'améliorer les infrastructures existantes ou d'en construire de nouvelles.
- **Synergies avec d'autres interventions de santé publique.** Les conditions propices à l'intégration des activités de lutte contre la méningite dans d'autres interventions de santé publique, telles que les programmes de vaccination ou les systèmes de surveillance des maladies, doivent être examinées afin que les ressources disponibles produisent le plus d'effets possible.
- **Collaboration avec les partenaires.** Une collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, tels que les donatrices et donateurs, les organisations non gouvernementales et les instituts de recherche, doit être envisagée pour tirer parti de ressources et d'expertise supplémentaires. Des partenariats doivent être établis au début du processus de planification pour garantir que toutes les parties prenantes s'alignent sur les objectifs du plan.

3.6 Plan d'atténuation des risques et d'intervention

Pour garantir une élaboration et une mise en œuvre efficaces des plans nationaux de lutte contre la méningite, il est important d'identifier les points faibles et les menaces potentielles précocement en utilisant les données recueillies au cours de la phase préparatoire. Ceci peut être réalisé en étudiant les risques à l'aide d'une matrice standard d'évaluation des risques, qui tient compte de la probabilité et de l'impact potentiel des risques identifiés et qui génère des mesures pour gérer ces risques ou les atténuer.



4. Phase de planification des activités

Quels sont les objectifs à atteindre et les activités à entreprendre ?

Comme exposé plus haut, l'élaboration de ces objectifs et activités doit reposer sur une approche pluridisciplinaire et être bien coordonnée pour intégrer les contributions pertinentes.

La formulation des objectifs et des activités du plan national doit reposer sur les conclusions de l'analyse de situation.

- Quelle est la situation épidémiologique et quelles sont les lacunes en matière de données à combler ?
- Quels sont les atouts des activités actuelles de lutte contre la méningite ?
- Quelles sont les principales lacunes et difficultés, et comment peut-on tenter de les régler ?
- Quelles activités actuelles peut-on renforcer ?
- Quelles nouvelles activités doit-on mettre au point ?
- Comment peut-on mieux intégrer la lutte contre la méningite – notamment le suivi des patientes et patients après l'épisode aigu – dans les SSP ?
- Comment peut-on créer ou renforcer des synergies avec d'autres programmes ou initiatives ?
- Quelles parties prenantes peuvent-elles jouer un rôle plus important, notamment celles qui n'ont encore jamais participé directement à la lutte contre la méningite ?

Pour obtenir des conseils plus précis, reportez-vous aux sections et encadrés pertinents plus haut dans ce manuel :

- Élargir le raisonnement, au-delà de la méningite (section 2.3)
- S'appuyer sur l'existant (section 2.4)
- Comment utiliser ce manuel ? (section 2.5)

Des « gains rapides » peuvent être identifiées – il s'agit d'activités qui peuvent être mises en place plus facilement que d'autres, et/ou avec des ressources limitées, et qui sont potentiellement source de progrès ou d'effets.

Pour faciliter la mise en œuvre et le suivi du plan, veuillez décrire de manière claire et précise les objectifs et les activités. Incluez les délais, les personnes/équipes/organismes responsables et tout autre renseignement utile.

Encadré 2. Activités au niveau infranational

L'équité étant un principe fondamental, et en fonction du contexte national spécifique et des conditions locales, il convient également d'examiner quand il peut être opportun de mener certaines activités aux niveaux infranationaux, notamment des provinces, districts et municipalités.

Ceci pourrait s'avérer une méthode solide pour étendre la mise en œuvre par :

- l'expérimentation d'activités innovantes avant l'évaluation et la transposition à plus grande échelle ;
- la création de partenariats avec des organismes locaux ou d'initiatives réalisées localement ;
- la promotion du financement et de la gestion des ressources à des niveaux intermédiaires.

4.1 Prévention et lutte contre les épidémies (pilier 1)

Objectifs

Les objectifs du plan national, en ce qui concerne le pilier Prévention et lutte contre les épidémies, peuvent inclure :

1. Élaborer des stratégies pertinentes localement pour prévenir les infections à *Neisseria meningitidis* (Nm), *Streptococcus pneumoniae* (Spn), *Haemophilus influenzae de type b* (Hib) et streptocoques du groupe B (SGB) ou les actualiser pour aboutir à une protection optimale des individus et, dans la mesure du possible, à une protection collective.
2. Introduire des vaccins efficaces et sûrs et/ou atteindre et/ou maintenir une couverture élevée des vaccins protégeant contre la méningite.
3. Etablir des plans actualisés et pragmatiques pour prévenir les flambées épidémiques de méningite et y faire face.
4. Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de vaccination dans le cadre des rassemblements de masse et des situations d'urgence humanitaire, selon le cas.
5. Tout autre objectif en rapport avec le contexte et les priorités du pays.

Domaines d'intervention

1. Introduction d'un contre Hib et Spn – vaccin anti-Hib et vaccin antipneumococcique conjugué (VPC) – et/ou atteinte et maintien de niveaux élevés de couverture par ces vaccins.
2. Élaboration et mise en œuvre de stratégies de vaccination antiméningococcique localement pertinentes.
3. Pour les pays situés dans la ceinture de la méningite : atteinte et maintien de niveaux élevés de couverture par le vaccin conjugué contre le méningocoque A (MenACV) et passage à une vaccination par le vaccin antiméningococcique conjugué multivalent.
4. Prévention de l'infection à SGB chez les nourrissons au moyen de stratégies spécifiques au contexte et/ou de l'introduction d'un vaccin anti-SGB, dès lors qu'il est disponible.
5. Prévention des flambées épidémiques de méningite et riposte (notamment lors des rassemblements de masse et dans les situations d'urgence humanitaire).

1. Vaccination anti-Hib et par le VPC

Activités suggérées

Introduction d'une vaccination anti-Hib/par le VPC

- Demander l'avis du groupe technique consultatif national sur la vaccination (GTCV) concernant l'introduction du vaccin anti-Hib/VPC.
- Intégrer les plans d'introduction du vaccin anti-Hib/VPC dans la planification de vaccination nationale globale et les outils et processus respectifs (stratégie nationale de vaccination [SNV], planification du portefeuille complet Gavi, s'il y a lieu, etc.).
- Intégrer le VPC/vaccin anti-Hib dans le Programme élargi de vaccination (PEV).

Augmenter/maintenir une couverture vaccinale élevée et une forte protection par le vaccin anti-Hib/VPC – actualisation de la politique de vaccination

- Intégrer le vaccin anti-Hib/VPC dans les efforts globaux de rattrapage vaccinal auprès des enfants manqués et d'augmentation et de maintien de la couverture vaccinale, conformément aux stratégies et plans de vaccination régionaux et nationaux, dans la droite ligne du Programme pour la vaccination à l'horizon 2030 (Vaccination 2030).
- Actualiser les stratégies de vaccination systématique et de rattrapage par le VPC sur la base des recommandations mondiales et régionales et des données épidémiologiques locales, selon le cas.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles autres initiatives/mesures (par exemple relatives à la lutte contre la pneumonie chez l'enfant) peut-on mettre à profit pour augmenter la couverture par le vaccin anti-Hib/VPC ?
- Existe-t-il des activités spécifiques en matière de vaccination anti-Hib/VPC qui seraient susceptibles d'augmenter la couverture et le niveau de protection global ?
- Doit-on demander au GTCV d'émettre une recommandation sur la confirmation/révision du calendrier de vaccination par le VPC et/ou sur le vaccin utilisé ?

2. Vaccination antiméningococcique (en dehors de la ceinture africaine de la méningite)

Activités suggérées

- Évaluer le fardeau de la méningite à méningocoque et, si nécessaire, élaborer des plans pour renforcer la surveillance (voir aussi le pilier 3).
- Demander l'avis du GTCV sur la vaccination antiméningococcique, le cas échéant.
- Si la vaccination antiméningococcique a déjà été mise en place chez les nourrissons, les enfants, les adolescents ou dans des populations particulières :
 - inclure des mesures visant à augmenter la couverture vaccinale ;
 - déterminer s'il est nécessaire d'étendre la vaccination à d'autres groupes, en fonction de l'évolution de l'épidémiologie ;
 - déterminer s'il est possible d'améliorer la protection collective (vaccination des porteurs/transmetteurs).

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles sont les données existantes sur la méningococcie invasive et quelles sont les lacunes en matière de données (voir aussi le pilier 3) ? Quels sont les sérogroupes prédominants dans les différentes populations ?
- Selon les besoins : où peut-on se procurer des données épidémiologiques supplémentaires (par exemple, établissements d'enseignement, associations professionnelles de praticiens en maladies infectieuses) ?
- Quels facteurs ont freiné la mise en place ou l'adoption de la vaccination antiméningococcique (manque de données épidémiologiques, prix des vaccins et/ou approvisionnement en vaccins, etc.) ?
- Quelles sont les populations les plus exposées à la méningococcie ? Des programmes de vaccination spécifiques doivent-ils être mis en œuvre pour les groupes à haut risque ?
- Si la vaccination a déjà été mise en œuvre : que peut-on faire pour augmenter la couverture – en s'intéressant particulièrement à des cibles autres que les enfants (par exemple, les adolescents) en synergie avec d'autres initiatives ?
- Tenir compte de la protection directe et de la protection indirecte conférées par les vaccins conjugués.
- Est-il judicieux d'envisager des stratégies différentes sur le court terme et le plus long terme, l'offre en vaccins étant susceptible de s'étoffer ?
- Que peut-on faire pour évaluer régulièrement l'effet des stratégies de vaccination et, si cela est pertinent compte tenu de l'évolution de l'épidémiologie, ajuster les stratégies (par exemple, un groupe de travail du GTCV) ?

3. Vaccination antiméningococcique dans la ceinture africaine de la méningite (MenACV et vaccin antiméningococcique conjugué multivalent)

Activités suggérées

Introduction du MenACV

- Demander l'avis du GTCV concernant la mise en place de la vaccination et les campagnes de rattrapage.
- Intégrer les plans d'introduction dans la planification de vaccination nationale globale et les outils et processus respectifs (SNV, planification du portefeuille complet Gavi...).
- Préparer l'introduction du vaccin dans le programme de vaccination systématique et les campagnes de rattrapage afin de vacciner les enfants nés après les campagnes préventives de masse.
- Introduire le MenACV dans le programme de vaccination systématique et mener des campagnes de rattrapage.

Augmentation/maintien d'une forte couverture par le MenACV

- Liaison avec les efforts globaux de rattrapage vaccinal auprès des enfants manqués et d'augmentation et de maintien de la couverture vaccinale, conformément aux stratégies et plans de vaccination régionaux et nationaux, et conformément avec l'activité 3 de Vaccination 2030.

Introduction du vaccin antiméningococcique conjugué multivalent

- Conduire une évaluation des risques d'épidémie de méningite.
- Demander l'avis du GTCV.
- Intégrer les plans d'introduction dans la planification de vaccination nationale globale et les outils et processus correspondants (SNV, planification du portefeuille complet Gavi...).
- Intégrer le vaccin antiméningococcique conjugué multivalent dans le programme de vaccination systématique (et, s'il y a lieu, avec des campagnes de vaccination de masse).

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles opportunités la vaccination MenACV peut-elle offrir pour augmenter la couverture des vaccins coadministrés (renforcement de la plateforme de la deuxième année de vie, augmentation de la couverture par le MCV1/MCV2...) ?
- Quels sont les obstacles à l'introduction du MenACV ?
- Envisager d'associer l'introduction du MenACV dans le calendrier de vaccination systématique avec une campagne de rattrapage, ce qui peut être éminemment favorable à la vaccination des enfants nés après les campagnes préventives de masse avec le MenACV. Ceci est essentiel pour éviter le risque de résurgence épidémique de l'infection à *N. meningitidis* du sérogroupe A (NmA).
- Quelles sont les données disponibles sur la méningococcie et les antécédents/risques d'épidémie ? Des lacunes en matière de données doivent-elles être comblées ?
- Comment intégrer au mieux l'introduction du MenACV et/ou du vaccin antiméningococcique conjugué multivalent dans la planification générale de mise en place de nouveaux vaccins ?
- Comment prévoir au mieux l'introduction du vaccin antiméningococcique conjugué multivalent en remplacement de la vaccination par le MenACV ?
- Voir aussi les éléments à prendre en compte dans le domaine d'intervention précédent sur la vaccination antiméningococcique en dehors de la ceinture de la méningite.

4. Prévention de l'infection à SGB chez les nourrissons

Activités suggérées

Épidémiologie

- Identifier les données nationales ou régionales existantes sur les maladies invasives à SGB, notamment la méningite et le sepsis.
- Recueillir des données et évaluer le fardeau des maladies invasives à SGB, notamment la méningite et le sepsis.

Élaboration de stratégies spécifiques du contexte

- Voir s'il serait possible de mettre en place ou de renforcer les stratégies de prévention des maladies à SGB (dans des zones prioritaires ou dans l'ensemble du pays).
- Mettre en place ou renforcer les stratégies de prévention des maladies à SGB.

Introduction du vaccin anti-SGB (vaccination maternelle)

- Prévoir l'introduction du vaccin anti-SGB pour les femmes enceintes, en amont de sa mise à disponibilité, et l'inclure, s'il y a lieu, dans les processus et outils de planification.
- Évaluer la plateforme de vaccination maternelle et les méthodes possibles pour la renforcer.
- Demander l'avis du GTCV sur l'introduction d'un vaccin anti-SGB (le cas échéant.).

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles mesures peut-on prendre pour estimer le fardeau des maladies à SGB (méningite, sepsis, autres) – ou améliorer les estimations –, en particulier chez les nourrissons (voir aussi le pilier 3) ?
- Comment mettre en place ou renforcer des politiques basées sur les risques ou de dépistage pour éviter la transmission des maladies à SGB pendant l'accouchement ?
- Dans quels milieux et/ou niveaux de soins de santé et/ou populations particulières une stratégie spécifique du contexte pourrait-elle être mise en place en priorité pour prévenir les infections à SGB (si cela n'a pas encore été fait) ?
- Si des politiques basées sur les risques ou de dépistage ont déjà été mises en œuvre : que pourrait-on faire pour les renforcer ou les étendre ?
- Comment peut-on anticiper et planifier efficacement l'introduction du vaccin anti-SGB ?
- Quels sont les plans existants et à venir pour renforcer les plateformes de vaccination maternelle ? Comment la vaccination contre les SGB peut-elle contribuer à étoffer les plateformes de vaccination maternelle ?
- En dehors des acteurs habituels de la vaccination, quelles parties prenantes doivent participer à la préparation d'une vaccination contre les SGB adaptée et efficace (par exemple, prestataires de soins prénatals, obstétriciens et obstétriciennes, spécialistes des maladies infectieuses) ?

5. Prévention des flambées épidémiques de méningite et riposte (notamment lors des rassemblements de masse et dans les situations d'urgence humanitaire)

Activités suggérées

- Élaborer et/ou actualiser une politique pour prévenir les épidémies de méningite et y riposter.
- Identifier les milieux, populations et événements à risque devant faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre des plans et des mesures de prévention et de riposte.
- Élaborer et actualiser régulièrement le plan de prévention et de riposte contre les épidémies.
- Veiller à disposer d'un stock permanent de fournitures (vaccins, produits de diagnostic et médicaments) pour prévenir les épidémies et y riposter, selon les besoins et conformément au plan de prévention et de riposte contre les épidémies.
- Élaborer des plans incluant la prévention des épidémies de méningite et les mesures prises pour y remédier, selon les besoins, en concertation avec d'autres mesures prises en faveur de la vaccination et de la santé dans les situations d'urgence humanitaire.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelle est la définition nationale d'une flambée épidémique/épidémie de méningite ?
- Faut-il intégrer le plan de prévention et de riposte contre les épidémies dans d'autres plans pour prévenir les flambées épidémiques d'autres maladies et y répondre ? Comment le rendre aussi réactif et efficace que possible ?
- Quels types de rassemblements de masse peuvent-ils présenter un risque particulier de transmission d'agents pathogènes responsables de la méningite et de flambées épidémiques de méningite ?
- Qui doit être responsable de l'élaboration des plans et stratégies de prévention et de riposte contre les épidémies ou participer à leur mise au point ?
- Tenir compte, s'il y a lieu, de la capacité de réaction qui permettra d'envoyer des demandes au Groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins (GIC) afin de vacciner de manière réactive.
- Quelles parties prenantes (par exemple, ONG) doivent-elles participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de prévention et de riposte contre les épidémies dans les situations d'urgence humanitaire, notamment dans les camps de réfugiés ?
- Pendant l'élaboration des activités, déterminer s'il est nécessaire de demander la validation technique et politique des stratégies et plans.

Autre(s) domaine(s) pertinent(s) pour le pays



4.2 Diagnostic et traitement (pilier 2)

Objectifs

Les objectifs du plan national, en ce qui concerne le pilier Diagnostic et traitement, peuvent inclure :

1. Renforcer et améliorer les stratégies de prise en charge des cas de méningite, notamment par un diagnostic réalisé à temps et un traitement fourni en temps opportun à tous les niveaux de soins.
2. Garantir et simplifier l'accès à la ponction lombaire et aux tests de diagnostic à tous les niveaux de soins pour les patientes et patients affectés par la méningite.
3. Garantir et simplifier l'accès aux traitements antimicrobiens et aux traitements d'appoint pertinents pour les patientes et patients affectés par la méningite bactérienne.
4. Concevoir et mettre en œuvre des orientations et des outils appropriés, spécifiques au contexte et de bonne qualité pour le diagnostic et le traitement des patientes et patients affectés par la méningite.
5. Prendre les mesures voulues pour que les interventions de diagnostic et de traitement de la méningite constituent un ensemble bien défini intégré dans les SSP et conforme aux stratégies nationales pour réaliser la CSU à tous les niveaux de soins.
6. Tout autre objectif en rapport avec le contexte et les priorités du pays.

Domaines d'intervention

1. Élaboration d'une stratégie de test nationale pour les cas suspects de méningite compte tenu des ressources humaines, infrastructurelles et financières disponibles.
2. Renforcement des moyens de diagnostic pour améliorer la prise en charge des cas cliniques (et la détection des flambées épidémiques).
3. Renforcement de l'accès à des traitements efficaces, sûrs et adaptés et fourniture de ces traitements aux personnes affectées par la méningite, notamment les antimicrobiens et traitements d'appoint.

1. Stratégie nationale de test

Activités suggérées

- Concevoir une stratégie nationale de test pour diagnostiquer la méningite, incluant un réseau de laboratoires opérationnels et intégrant une capacité de montée en puissance dans les zones à potentiel épidémique.
- Inventorier les pratiques de ponction lombaire existants dans les établissements de santé à tous les niveaux de soins (primaire, secondaire et tertiaire).
- Évaluer la capacité des laboratoires en matière de test des échantillons à tous les niveaux de soins (primaire, secondaire et tertiaire).
- Créer des filières précises pour le prélèvement des échantillons, leur transport et les tests dans les établissements de santé et les laboratoires.
- Établir un système de gestion de l'information de laboratoire fonctionnel pour garantir la traçabilité des résultats et faciliter le partage de données, notamment avec les personnels de santé s'occupant de la patiente ou du patient.
- Créer et/ou renforcer la coordination avec les laboratoires de référence internationaux et les centres collaborateurs de l'OMS pour le contrôle de la qualité et l'évaluation externe de la qualité.
- Envisager d'intégrer des moyens de diagnostic en provenance d'autres secteurs, notamment les établissements d'enseignement et les instituts de recherche.
- Élaborer une stratégie adaptée au contexte pour le diagnostic du portage maternel des SGB et de l'infection chez le nourrisson.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Existe-t-il un réseau de test national pleinement opérationnel et satisfaisant aux besoins en matière de tests de diagnostic ? Quels facteurs doit-on prendre en compte lors de la conception ou de l'amélioration d'une stratégie de test nationale ?
- Quels sont les principaux freins à la réalisation de ponctions lombaires à tous les niveaux de soins ? Comment peut-on les utiliser pour éclairer la mise au point d'une stratégie de test nationale ?
- Quelle est la capacité des laboratoires en matière de test des échantillons à tous les niveaux de soins ? Comment peut-on l'utiliser pour apporter les éclairages nécessaires à la mise au point d'une stratégie de test nationale ?
- Comment peut-on associer la stratégie de test avec les services de SSP existants ou l'intégrer dans ces services ?
- Quelles sont les occasions spécifiques existantes pour tirer parti des services de SSP afin de mettre en œuvre la stratégie de test nationale ?
- Existe-t-il des plateformes ou des programmes au sein des services de SSP qui puissent être utilisés pour appuyer l'élaboration et/ou la mise en œuvre de la stratégie de test ?

Éléments potentiels à prendre en compte continuent

- Quelles ressources humaines, infrastructurelles et financières peut-on affecter et/ou mobiliser pour mettre en œuvre une stratégie de test nationale adaptée au contexte ?
- Quelles sont les données actuellement disponibles sur les pratiques en matière de ponction lombaire dans les établissements de santé périphériques ainsi que dans les hôpitaux de district, régionaux et nationaux ?
- Quelles sont les ressources humaines et infrastructurelles actuellement allouées aux analyses en laboratoire des échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) (dont la mise en culture et les tests moléculaires) ?
- Comment peut-on incorporer les tests de diagnostic rapide (TDR) dans la stratégie de test nationale ?
- Quels sont les laboratoires de référence internationaux et les centres collaborateurs de l'OMS dans la région ?
- Quels facteurs doit-on prendre en compte pour concevoir une stratégie de test du portage maternel des SGB et de l'infection chez le nourrisson ?
- Quelle est la prévalence nationale de l'infection à SGB chez les femmes enceintes et les nourrissons ?
- Quelles zones doit-on définir comme prioritaires lors de l'élaboration d'une stratégie adaptée au contexte pour le diagnostic du portage maternel des SGB et de l'infection chez le nourrisson ?

2. Diagnostic

Activités suggérées

Lignes directrices et protocoles nationaux

- Élaborer et diffuser des politiques, lignes directrices ou protocoles nationaux mettant en avant la collecte, le transport et le test, dans les délais nécessaires, des échantillons de LCR et d'autres échantillons recommandés en tant qu'outils indispensables au diagnostic de la méningite.

Accès aux produits de diagnostic

- Effectuer un suivi régulier des stocks nationaux et de l'approvisionnement des établissements de santé en trousse de ponction lombaire, matériel de transport des échantillons de LCR, tests de diagnostic et réactifs de laboratoire.
- Distribuer, réapprovisionner et/ou prépositionner les trousse de ponction lombaire, le matériel de transport des échantillons de LCR, les tests de diagnostic et les réactifs de laboratoire pour garantir que ces produits sont disponibles en permanence dans les établissements de santé.
- Assurer la sélection et l'achat des tests de diagnostic (notamment des TDR) et des réactifs de laboratoire en fonction de leur utilisation et de leur accessibilité.

Renforcement des capacités

- Mettre en œuvre une formation et une supervision adaptées des personnels de santé participant à la collecte d'échantillons et à la réalisation des TDR.
- Mettre en œuvre une formation et une supervision adaptées des personnels de santé en matière de stratégies de communication avec les patientes et patients concernant la ponction lombaire afin d'atténuer la mésinformation et d'améliorer l'acceptabilité de cet acte médical.
- Mettre en œuvre une formation et une supervision adaptées du personnel de laboratoire participant aux analyses en laboratoire et/ou au transport des échantillons.
- Identifier et former les prestataires de services logistiques pour rationaliser le transport des échantillons vers les laboratoires de référence.
- Mettre en œuvre une formation et une supervision adaptée des personnels de santé intervenant dans les soins prénatals pour renforcer les capacités de dépistage des SGB chez les femmes enceintes, conformément à la stratégie de test des SGB locale.

Mobilisation communautaire

- Organiser et mettre sur les rails des campagnes de sensibilisation des communautés pour améliorer l'acceptation de la ponction lombaire à visée diagnostique afin de garantir une prise en charge des cas rapide et efficace.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quels sont les principaux obstacles à une disponibilité continue des produits de diagnostic dans les établissements de santé ?
- Quels TDR et tests d'agglutination au latex sont-ils actuellement disponibles à la sélection et à l'achat ? Pour chacun d'entre eux, tenir également compte de leur opportunité, leur abordabilité et leur accessibilité.
- Existe-t-il des lignes directrices nationales en matière de diagnostic de la méningite ? Des révisions ou des mises à jour pertinentes sont-elles justifiées ?
- Existe-t-il des lignes directrices internationales ou des protocoles régionaux en matière de diagnostic de la méningite qui soient applicables dans votre situation ?
- Quelles stratégies peut-on mettre en œuvre pour garantir la mise à disposition des fournitures nécessaires au diagnostic de la méningite (par exemple, trousses de ponction lombaire) à tous les niveaux de soins ?
- Quelles stratégies peut-on mettre en œuvre pour garantir la mise à disposition des fournitures nécessaires au diagnostic de la méningite dans les structures de soins de santé primaires, en tenant compte de leur utilisation potentielle également pour d'autres maladies ?
- Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour garantir que les personnels de santé réalisent une ponction lombaire lorsque cela est indiqué sur le plan clinique ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ?
- Comment peut-on former les prestataires de SSP et leur donner les moyens de diagnostiquer efficacement les cas de méningite dans leur contexte spécifique ?
- Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour garantir que les échantillons sont testés dans le niveau de laboratoire pertinent et que les résultats sont notifiés et partagés de manière adéquate ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ?
- Quels sont les principaux défis logistiques à relever pour garantir que les échantillons sont transportés vers les laboratoires de référence dans les délais impartis ? Comment peut-on relever efficacement ces défis ?
- Comment peut-on former les professionnelles et professionnels de santé en soins prénatals et leur donner les moyens de dépister efficacement le portage maternel des SGB ?
- Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour garantir que les communautés acceptent la ponction lombaire comme un outil indispensable au diagnostic de la méningite ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ?

3. Accès au traitement

Activités suggérées

Lignes directrices et protocoles nationaux

- Élaborer et diffuser des lignes directrices et des protocoles sur le traitement pour toutes les tranches d'âge et les principales causes de méningite bactérienne (Nm, Spn, Hib, SGB), sur la base de l'épidémiologie de la maladie et des profils de résistance aux antibiotiques (lorsqu'ils sont connus) observés localement.
- Élaborer et diffuser des lignes directrices et des protocoles sur la chimioprophylaxie de la méningite bactérienne dans un contexte d'épidémie ou non.
- Garantir l'intégration des recommandations thérapeutiques dans les lignes directrices nationales existantes et les programmes en cours de bon usage des antimicrobiens au niveau du district, de la région et/ou du pays, selon le cas.
- Veiller à établir des liens entre les recommandations thérapeutiques et les filières d'orientation et services de SSP existants.

Mise à disposition des traitements

- Effectuer un suivi régulier des stocks nationaux et des fournitures des établissements de santé (médicaments, dont les antimicrobiens, et dispositifs médicaux) utilisés dans le traitement de la méningite (pouvant également être utilisés pour d'autres maladies).
- Estimer les besoins en antimicrobiens pour l'utilisation courante et lors d'une flambée épidémique, prépositionner les stocks d'antimicrobiens dans les zones à potentiel épidémique et créer des canaux de distribution vers les établissements de santé périphériques.
- Réapprovisionner les établissements de santé en fournitures (médicaments, dont les antimicrobiens, et dispositifs médicaux) utilisées dans le traitement de la méningite (et d'autres maladies) pour garantir une disponibilité continue.

Renforcement des capacités

- Planifier et mettre en œuvre des initiatives de formation des personnels de santé à la prise en charge des cas, l'accent étant mis sur l'importance du traitement précoce et le risque de résistance aux antimicrobiens.
- Mettre en œuvre une formation et une supervision adaptée des personnels de santé intervenant lors des accouchements pour renforcer les pratiques de prophylaxie antibiotique intrapartum chez les femmes enceintes.

Mobilisation communautaire

- Organiser et mettre sur les rails des campagnes de sensibilisation du public au cours d'une épidémie pour informer les communautés sur l'importance d'un traitement précoce.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quels sont les principaux freins empêchant les patientes et patients affectés par la méningite de recevoir rapidement un traitement efficace ? Comment peut-on tenter de régler au mieux ces difficultés ?

Éléments potentiels à prendre en compte continuent

- Quelles sont les difficultés en matière de prévention d'un usage inadapté, abusif et/ou inapproprié des antimicrobiens chez les patientes et patients avec suspicion de méningite ? Comment peut-on tenter de régler au mieux ces difficultés ?
- Quels sont les principaux freins entravant la disponibilité continue des antimicrobiens et des dispositifs médicaux utilisés pour traiter la méningite dans les établissements de santé ?
- Existe-t-il des lignes directrices nationales en matière de traitement de la méningite ? Des révisions ou des mises à jour pertinentes sont-elles justifiées ?
- Quels sont les lignes directrices internationales ou les protocoles régionaux en matière de traitement et/ou de chimioprophylaxie de la méningite qui pourraient être applicables dans votre situation ?
- Existe-t-il des données sur l'utilisation de traitements antimicrobiens empiriques chez les patientes et patients avec une suspicion de méningite ?
- Existe-t-il des données sur l'utilisation d'un traitement d'appoint chez les patientes et patients atteints de méningite ?
- Quelle est la prévalence locale de la résistance à la pénicilline ou aux céphalosporines parmi les souches de Spn ?
- Existe-t-il des données sur l'émergence d'une résistance aux antimicrobiens parmi les souches de Nm ?
- Existe-t-il des programmes de bon usage des antimicrobiens appliqués dans les établissements de santé ? Si tel est le cas, à quel niveau de soins sont-ils mis en œuvre ? Quel est votre bilan d'expérience après la mise en œuvre de programmes de bon usage des antimicrobiens dans votre situation ?
- Quelles stratégies peut-on mettre en œuvre pour garantir la mise à disposition des fournitures nécessaires au traitement de la méningite (par exemple, antimicrobiens) à tous les niveaux de soins ?
- Quelles stratégies peut-on mettre en œuvre pour garantir la mise à disposition des antimicrobiens dans les structures de soins de santé primaires, en tenant compte de leur utilisation potentielle pour d'autres maladies ?
- Comment peut-on former les prestataires de SSP et leur donner les moyens de traiter efficacement les cas de méningite dans leur contexte spécifique ?
- Comment peut-on former les professionnelles et professionnels de santé intervenant lors des accouchements et leur donner les moyens d'identifier et de prendre en charge les femmes enceintes porteuses de SGB et nécessitant une prophylaxie antibiotique intrapartum ?
- Quelles sont les principales difficultés rencontrées entravant la bonne sensibilisation des communautés à l'importance d'un traitement précoce ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ?

Autre(s) domaine(s) pertinent(s) pour le pays

4.3 Surveillance des maladies (pilier 3)

Objectifs

Les objectifs du plan national, en ce qui concerne le pilier Surveillance des maladies, peuvent inclure :

1. Élaborer et mettre en œuvre des systèmes de surveillance intégrés des principaux agents pathogènes responsables de la méningite et les renforcer.
2. S'assurer que la surveillance des principaux agents pathogènes responsables de la méningite est intégrée dans un système de surveillance des maladies évitables par la vaccination, avec une mise en commun des fonctions de surveillance, le cas échéant.
3. Veiller à ce que les données de surveillance soient mises à la disposition de toutes les principales parties prenantes et utilisées pour éclairer la prise de décision en matière de santé publique.
4. Renforcer les systèmes de surveillance et de notification précoce de la méningite, conformément au Règlement sanitaire international (2005) et aux priorités nationales, et renforcer les capacités de collecte et d'analyse de données, y compris au sujet des séquelles.
5. Tout autre objectif en rapport avec le contexte et les priorités du pays.

Domaines d'intervention

1. Adopter, intégrer et mettre en œuvre des normes minimales pour la surveillance épidémiologique des principaux agents pathogènes responsables de la méningite.
2. Adopter, intégrer et mettre en œuvre des normes minimales pour la surveillance en laboratoire des principaux agents pathogènes responsables de la méningite.
3. Adopter, intégrer et mettre en œuvre des normes minimales pour la gestion des données en tant qu'élément essentiel de la surveillance des principaux agents pathogènes responsables de la méningite.

1. Épidémiologie

Activités suggérées

- Adopter des définitions de cas normalisées de la méningite et les diffuser à tous les établissements de santé.
- Adopter et mettre en œuvre des seuils d'alerte et des seuils épidémiques pour la riposte aux flambées épidémiques.
- Élaborer des modes opératoires normalisés pour compiler et analyser les données de surveillance sur les principaux agents pathogènes responsables de la méningite (Nm, Spn, Hib) et effectuer un suivi des tendances et des profils, notamment en matière de résistance aux antimicrobiens.
- Renforcer les compétences en désignant, formant et supervisant des agentes et agents de surveillance au niveau du sous-district, du district, de la province/région et du pays.
- Veiller à ce que les mesures de santé publique prises pour lutter contre la méningite soient systématiquement étayées par des données de surveillance actualisées.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour renforcer le système de surveillance existant en ce qui concerne les principaux agents pathogènes responsables de la méningite ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ? Veuillez également tenir compte des ressources humaines et infrastructurelles disponibles.
- Sur la base des ressources disponibles, examiner si le système de surveillance national existant peut contribuer à la mise en place d'une surveillance fondée sur l'identification des cas ou au renforcement de la surveillance globale.
- L'évolution de l'incidence de la méningite et de la mortalité liée à cette maladie fait-elle l'objet d'un suivi systématique ?
- L'évolution des profils de résistance aux antimicrobiens des agents pathogènes responsables de la méningite fait-elle l'objet d'un suivi approprié compte tenu de la capacité existante des laboratoires ?
- Existe-t-il des définitions de cas normalisées nationales de la méningite ? Si tel n'est pas le cas, les définitions de cas normalisées actuelles de l'OMS pour la méningite sont-elles applicables dans votre situation ?
- Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour diffuser les définitions de cas normalisées et encourager leur utilisation ? Existe-t-il des exemples réussis de mise en œuvre de définitions de cas normalisées d'autres maladies évitables par la vaccination dans votre situation ?
- Quels sont les lacunes et points faibles actuels du système de surveillance existant qui peuvent être améliorés en élaborant des modes opératoires normalisés ?

2. Laboratoire

Activités suggérées

- Renforcer les capacités de validation nationales pour garantir l'identification des espèces (par mise en culture ou tests moléculaires), la détermination du sérotype ou le sérotypage et le test de la sensibilité aux antimicrobiens dans les laboratoires de référence.
- Mettre en place ou renforcer la surveillance moléculaire et faciliter le partage de données sur les séquences génomiques.
- En l'absence de moyens de surveillance moléculaire avancés, s'assurer que les liens avec les centres collaborateurs de l'OMS et/ou les laboratoires régionaux de référence sont opérationnels.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quels sont les moyens actuels du laboratoire pour garantir l'identification des agents pathogènes par mise en culture ou tests moléculaires ?
- Quels sont les moyens actuels du laboratoire pour la réalisation des tests de sensibilité aux antimicrobiens des agents pathogènes responsables de la méningite ?
- Comment peut-on mettre en place ou renforcer la surveillance moléculaire dans le cadre du système de surveillance de la méningite ?

3. Gestion des données

Activités suggérées

- Veiller à l'existence d'un maillage opérationnel et de mesures conjointes entre les laboratoires et les activités de surveillance.
- Veiller à intégrer la surveillance de la méningite dans les systèmes de surveillance intégrée des maladies infectieuses (telle que la surveillance intégrée de la maladie et riposte (SIMR)) et à encourager chaque occasion de synergie entre les programmes de lutte contre la méningite et les programmes de lutte contre d'autres maladies à potentiel épidémique.
- Veiller à intégrer la surveillance de la méningite dans les plateformes électroniques régionales et mondiales existantes (par exemple, DHIS-2, EWARS, SORMAS). Simplifier l'utilisation des plateformes numériques pour encourager le partage d'informations en temps réel.
- Adopter et surveiller les indicateurs clefs de performance de la surveillance.
- Élaborer de solides mécanismes de notification pour rationaliser le partage de données entre les systèmes de surveillance nationaux et internationaux.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quels sont les conditions propices et les freins à l'intégration de la surveillance de la méningite dans un système de surveillance intégrée ? Comment peut-on tenter de régler les éventuelles difficultés ? Existe-t-il des synergies mobilisables pour renforcer la surveillance ?
- Quels sont les freins et les conditions propices à la mise en œuvre d'une plateforme électronique comme méthode de surveillance intégrée qui inclut les agents pathogènes responsables de la méningite ? Comment peut-on tenter de régler les éventuelles difficultés ?
- Considérer les plateformes électroniques ou les systèmes existants comme une occasion de mettre en œuvre une surveillance intégrée de la méningite.
- Existe-t-il des mécanismes pour assurer la coordination entre les systèmes de surveillance nationaux et internationaux ?
- Comment la notification des données nationales au niveau régional peut-elle être renforcée ou améliorée ?

Autre(s) domaine(s) pertinent(s) pour le pays

4.4 Soutien et soins (pilier 4)

Objectifs

Les objectifs du plan national, en ce qui concerne le pilier Soutien et soins pour les personnes affectées par la méningite, peuvent inclure :

1. Renforcer et améliorer l'identification et la prise en charge précoces des séquelles de la méningite, quelle que soit sa cause, à tous les niveaux de soins et dans les structures de soins communautaires.
2. Garantir et promouvoir une offre en soins et services de soutien appropriés et l'accès à ces soins et services pour les personnes affectées par la méningite, quelle que soit sa cause, sans omettre leur famille et les personnes chargées des soins.
3. Tout autre objectif en rapport avec le contexte et les priorités du pays.

Domaines d'intervention

4. Garantir la mise à disposition de services et de ressources pour le diagnostic, le traitement et les soins des personnes présentant des séquelles de la méningite.
5. Créer des services et des systèmes de soutien pour accompagner les personnes affectées par les séquelles de la méningite pendant leur rétablissement et la prise en charge au long cours.
6. Mettre en œuvre des programmes à assise communautaire sensibilisant aux séquelles de la méningite et aux services de soutien disponibles, dans le but de limiter la stigmatisation, de renforcer la participation communautaire et d'offrir une assistance continue aux personnes affectées et à leur famille.
7. Favoriser les collaborations et partenariats entre les entités publiques et les organisations de la société civile pour garantir une approche coordonnée de la prévention, du traitement et des soins des séquelles de la méningite.
8. Promouvoir les activités de recherche axées sur l'enrichissement des connaissances sur les séquelles de la méningite et sur la consolidation globale des connaissances afin d'optimiser les pratiques et politiques basées sur des données probantes.

1. Analyse de situation

Activités suggérées

- Recenser les principales parties prenantes et les services existants intervenant dans la sensibilisation aux séquelles et au handicap, le diagnostic, le traitement, la recherche et le soutien afin de comprendre leurs besoins et préférences, d'identifier les insuffisances en matière de prestation de services et de planifier des activités en faveur de l'engagement et de l'autonomisation des parties prenantes.
- Comprendre les connaissances et les idées sur les séquelles de la méningite, aux niveaux national et local, afin de préparer des messages pour combler les lacunes et d'élaborer des supports de communication adaptés à chaque public visé.
- Étudier et identifier les insuffisances en matière de connaissances, de représentations et de pratiques des professionnelles et professionnels de santé spécialistes et non spécialistes concernant le diagnostic, le traitement et le soin des séquelles.
- Identifier les freins à l'accès aux services et systèmes de soutien et à leur utilisation, avec le concours des associations de personnes handicapées et d'autres réseaux, dans la mesure du possible.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quels sont les services actuellement disponibles pour la sensibilisation aux séquelles et au handicap, leur diagnostic, leur traitement, la recherche et le soutien ? Quelles sont les principales insuffisances dans la prestation de ces services ?
- Quelles organisations agissent actuellement dans votre pays en faveur des droits des personnes handicapées ? Quelles sont les difficultés auxquelles ces organisations sont confrontées qui pourraient les empêcher d'atteindre leurs objectifs ?
- Quelles sont les données actuellement disponibles concernant les idées et les connaissances sur les séquelles de la méningite au sein des communautés ?
- Existe-t-il des programmes à assise communautaire proposant un traitement ou un soutien aux personnes présentant des séquelles (par exemple, déficience auditive ou visuelle, épilepsie, troubles neurocognitifs ou faiblesse focale) ?
- Quelles sont les données actuellement disponibles concernant les idées et les connaissances sur les séquelles de la méningite parmi les personnels de santé spécialistes et non spécialistes ?
- Y a-t-il des milieux ou des zones spécifiques où il serait plus pertinent et/ou facile de démarrer certaines activités particulières avant de les transposer à plus grande échelle ?

2. Diagnostic, traitement et soin des séquelles

Activités suggérées

Lignes directrices et protocoles nationaux

- Élaborer, adapter et mettre en œuvre des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en matière de détection, de suivi et de prise en charge des séquelles de la méningite.
- Utiliser des approches pluridisciplinaires, en faisant une large place à la communication, pour les prestataires de tous les niveaux, sans omettre de préciser des filières précises d'orientation, de réorientation et d'accès aux services au delà des soins primaires.
- Élaborer et mettre en œuvre des modèles de soins intégrés dans les secteurs sanitaire et social, s'étendant de l'identification et du diagnostic des séquelles à la réadaptation.

Accès aux technologies d'assistance et aux traitements

- Améliorer l'offre en technologies d'assistance utilisées pour prendre en charge les séquelles de la méningite (par exemple, aides auditives, implants cochléaires) et l'accès à ces technologies.
- Garantir la mise à disposition de médicaments pour la prise en charge des séquelles (par exemple, antiépileptiques) et l'accès à ces médicaments.

Renforcement des capacités

- Former les personnels de santé, notamment les médecins et les généralistes, au diagnostic et à la prise en charge des séquelles de la méningite.
- Former les agentes et agents de santé communautaires, le personnel infirmier, les sages-femmes, les travailleuses et travailleurs sociaux et le corps enseignant à l'identification et à la prise en charge des séquelles de la méningite.
- Identifier les compétences requises pour le diagnostic et la prise en charge des séquelles. Veiller à l'intégration dans les programmes de formation initiale et de formation en cours d'emploi.

Mobilisation communautaire

- Promouvoir les programmes à assise communautaire pour : i) identifier les séquelles et les handicaps sur la base d'instruments normalisés (en particulier pour le développement de l'enfant et l'audition) et orienter les patientes et patients à des fins d'évaluation et pour qu'ils reçoivent les soins appropriés ; ii) prodiguer des soins, apporter un soutien et des services de soins post-hospitalisation aux personnes, aux familles et aux communautés affectées par la méningite (par exemple, soutien psychosocial).
- Faire participer les praticiennes et praticiens de médecine traditionnelle et complémentaire et les guérisseuses et guérisseurs mystiques au diagnostic et au traitement des séquelles de la méningite.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Existe-t-il actuellement des lignes directrices nationales sur le diagnostic, le traitement et le soin des séquelles de la méningite ?
- En l'absence de lignes directrices complètes, un document opérationnel succinct pourrait-il être mis à disposition au niveau de soins concerné pour guider le diagnostic, l'orientation et le traitement ?
- Quelles sont les principaux obstacles empêchant les personnes présentant des séquelles de la méningite de recevoir un diagnostic et un traitement rapides et efficaces ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ?
- Quels sont les principaux défis logistiques à relever pour garantir la suite du traitement des personnes sorties de l'hôpital après une méningite (par exemple, transport, absence d'orientation) ? Comment peut-on faire relever efficacement ces défis ?
- Existe-t-il des données sur l'utilisation des technologies d'assistance (par exemple, aides auditives, implants cochléaires) chez les personnes présentant des séquelles de la méningite ?
- Quels sont les principaux obstacles entravant la disponibilité continue des technologies d'assistance et des médicaments utilisés pour prendre en charge les séquelles de la méningite dans les établissements de santé ? Comment peut-on tenter de lever efficacement ces freins ?
- Quelles sont les difficultés éventuelles rencontrées pour garantir que les personnels de santé bénéficient d'une formation sur l'identification et la prise en charge des séquelles de la méningite ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ?
- Comment le plan national de lutte contre la méningite peut-il être exploité pour soutenir d'autres programmes et initiatives visant à prodiguer des soins et à apporter des services de soutien et de réadaptation en cas de handicaps comparables ? Comment ces programmes et initiatives peuvent-ils servir de leviers pour mettre en œuvre le plan national de lutte contre la méningite ?
- Existe-t-il actuellement des programmes à assise communautaire abordant l'identification et/ou la prise en charge des séquelles de la méningite ? Quelles ressources humaines, infrastructurelles et financières peut-on affecter et/ou mobiliser pour élaborer et mettre en œuvre de telles initiatives ?
- Comment les praticiennes et praticiens de médecine traditionnelle et complémentaire et les guérisseuses et guérisseurs mystiques peuvent-ils participer efficacement au diagnostic et à la prise en charge des séquelles de la méningite ?

3. Services et systèmes de soutien

Activités suggérées

- Collaborer avec toutes les parties intéressées et tous les secteurs concernés afin d'améliorer les services et systèmes de soutien pour : i) les enfants et les personnes handicapées, y compris celles qui présentent des séquelles de la méningite ; ii) les familles et les aidantes et aidants des personnes affectées par la méningite.
- Renforcer les partenariats entre les gouvernements et les organisations de la société civile, notamment celles en faveur des personnes handicapées et d'autres réseaux, afin que les personnes présentant des séquelles, leur famille et leurs aidantes et aidants ainsi que celles qui ont perdu un proche en raison de la méningite bénéficient de services efficaces et de qualité respectant les normes et cadres internationaux relatifs aux droits humains.
- Garantir que les aidantes et aidants non rémunérés reçoivent un soutien (financier ou en nature) adéquat, notamment une formation, afin de consolider leurs connaissances et leurs compétences concernant la prise en charge des séquelles de la méningite.
- Créer des services téléphoniques de conseil et des sites Web nationaux offrant des informations accessibles sur l'autoprise en charge et sur la planification et l'organisation des soins et services pour les séquelles de la méningite et l'accès à ces soins et services.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles ressources humaines, infrastructurelles et financières peut-on affecter et/ou mobiliser pour mettre en œuvre une stratégie de soutien au système national?
- Existe-t-il des données sur le soutien (financier ou en nature), notamment la formation, visant à consolider les connaissances et les compétences concernant les séquelles de la méningite pour les personnes atteintes de méningite et leurs aidantes et aidants ?
- Quel est le bilan d'expérience à la suite de la mise en œuvre de programmes de réadaptation et de soutien social dans votre situation ?

4. Sensibilisation aux séquelles et réduction de la stigmatisation

Activités suggérées

- Renforcer la capacité des associations de personnes porteuses d'un handicap lié à la méningite à combattre la stigmatisation et la discrimination et à comprendre, promouvoir et protéger les droits humains en s'appuyant sur les expériences vécues, dans le respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies.
- Élaborer une feuille de route pour réduire la stigmatisation des personnes présentant des séquelles de la méningite, pour planifier des campagnes de déstigmatisation à destination des employeuses et employeurs, des éducatrices et éducateurs, des travailleuses et travailleurs sociaux et de la communauté dans son ensemble, et pour intégrer des outils et des pratiques visant à réduire la stigmatisation dans les politiques et les plans.
- Utiliser les médias sociaux pour diffuser des informations, toucher le plus de personnes possible et favoriser l'inclusion et l'engagement, en particulier chez les jeunes.
- Fournir des informations pertinentes et actualisées aux personnes et aux aidantes et aidants affectés par la méningite concernant l'accès aux services de prise en charge des séquelles, ainsi que sur les droits des personnes handicapées garantis par les politiques et lois nationales et par les instruments internationaux relatifs aux droits humains.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles sont les difficultés rencontrées au sein de la communauté pour prévenir la stigmatisation et la discrimination envers les personnes présentant des séquelles de la méningite et les handicaps associés ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ?
- Quelles stratégies de communication seraient les plus adaptées dans votre situation pour combattre la stigmatisation et la discrimination associées aux séquelles de la méningite ?

5. Recherche

Activités suggérées

- Favoriser les recherches sur l'épidémiologie, les causes, les comorbidités, le diagnostic, la prise en charge et la prévention des séquelles de la méningite au cours de l'existence.
- Apporter un soutien à la recherche sur la mise en œuvre pour éclairer le développement à plus grande échelle d'interventions et de modèles de soins efficaces pour les personnes présentant des séquelles.
- Encourager la recherche pluridisciplinaire sur les aspects sociaux des séquelles (par exemple, inclusion sociale, respect des droits humains et relations) et sur les liens entre la pauvreté et d'autres déterminants sociaux de la santé et résultats en matière de santé.
- Faire participer activement et épauler les personnes présentant des séquelles de la méningite, leur famille et leurs aidantes et aidants pour la définition des priorités et la conception, la planification, l'exécution et l'évaluation des recherches afin de garantir un impact le plus important possible.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles sont les principales difficultés éventuelles rencontrées pour garantir que les professionnelles et professionnels de santé peuvent mener des recherches sur les séquelles de la méningite au sein des universités et des structures d'enseignement ? Comment peut-on faire face efficacement à ces difficultés ?
- Comment les personnes présentant des séquelles de la méningite, leur famille et les personnes chargées des soins peuvent-elles participer activement aux activités de recherche ?

Autre(s) domaine(s) pertinent(s) pour le pays

4.5 Sensibilisation et mobilisation (pilier 5)

Objectifs

Les objectifs du plan national, en ce qui concerne le pilier Sensibilisation et mobilisation, peuvent inclure :

1. Sensibiliser toutes les populations à la méningite (symptômes/signes et conséquences).
2. Augmenter la demande en vaccins, traitements et soins – sans omettre ceux pour les séquelles de méningite.
3. Augmenter la capacité d'action des communautés et des organisations de la société civile en tant qu'acteurs clefs du plan national de lutte contre la méningite.
4. Augmenter les ressources pour vaincre la méningite.
5. Tout autre objectif en rapport avec le contexte et les priorités du pays.

Domaines d'intervention

1. Engagement des communautés et des organisations de la société civile afin d'établir des relations utiles avec les populations affectées.
2. Consolidation des connaissances et amélioration de la réponse aux besoins de la communauté, notamment en renforçant les liens avec les communautés et les organisations de la société civile.
3. Communication, sensibilisation et mobilisation des ressources.

1. Engagement des communautés et des organisations de la société civile

Activités suggérées

- Inventorier les partenaires, les structures communautaires existantes et les organisations de la société civile.
- Identifier les domaines dans lesquels ces parties prenantes pourraient collaborer à des activités visant à vaincre la méningite.
- Informer les parties prenantes de la communauté et de la société civile sur la feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030 et le plan national de lutte contre cette maladie.
- Élaborer un plan pour l'engagement continu de la société civile (notamment par une représentation des personnes affectées par la méningite, des organisations de la société civile et des structures communautaires dans les réunions de planification officielles).

Éléments potentiels à prendre en compte

- Les parties prenantes peuvent inclure, entre autres, les chefs et groupes coutumiers et les personnalités religieuses et groupes religieux, les comités sanitaires communautaires, les volontaires locaux, les établissements scolaires et organisations de la société civile, notamment les associations de personnes atteintes de méningite et celles représentant les personnes handicapées (notamment celles présentant une déficience auditive).
- Existe-t-il des organisations de la société civile nationales en lien avec la méningite ? Existe-t-il d'autres organisations de la société civile – par exemple pour la vaccination ou les personnes vivant avec un handicap – susceptibles de jouer un rôle dans la promotion de la mise en œuvre de ce plan ?
- Quels autres partenaires peuvent participer aux activités de sensibilisation à la méningite ? L'annexe 1 peut apporter des pistes.
- Réfléchir à la pertinence de créer un groupe de travail pour faciliter l'échange d'informations et la collaboration avec les organisations de la société civile et les communautés.

2. Comprendre les besoins des communautés et y répondre, notamment par des liens étroits avec les organisations de la société civile et les communautés

Activités suggérées

Recherche et collecte d'informations

- Évaluer la compréhension de la méningite par la communauté, notamment des risques et facteurs qui facilitent ou freinent le comportement de recours aux soins.
- Identifier des questions de recherche possibles à étudier s'intéressant à la mécompréhension du risque de méningite et à un comportement de recours aux soins insuffisant.
- Mener des recherches et/ou recueillir des informations de manière à mieux répondre aux besoins de la communauté, le cas échéant.

Engagement des communautés et des organisations de la société civile

- Dans le cadre du plan de collaboration avec la société civile, organiser à intervalles réguliers des consultations et réunions avec la société civile pour actualiser le plan national de lutte contre la méningite.

Éléments potentiels à prendre en compte

- La communauté et la société civile peuvent être consultées sur leur niveau de sensibilisation à la maladie, leur expérience du traitement, des services de soins post-hospitalisation et de soutien dans le cadre de l'évaluation des besoins, notamment au moyen d'enquêtes et de questionnaires, de réunions communautaires, d'entretiens avec des informateurs clefs et d'un examen des documents.
- Comment rassembler facilement des informations sur les facteurs d'incitation et les obstacles à la demande de vaccination contre la méningite, de diagnostic et de traitement de la méningite, de diagnostic des séquelles et de soutien et soin des séquelles ?
- En quoi la recherche et les informations disponibles peuvent-elles contribuer à éclairer la mise à jour du plan ?
- Quel rôle les communautés et les organisations de la société civile peuvent-elles jouer dans le suivi et l'évaluation du plan ?

3. Communication, sensibilisation et mobilisation des ressources

Activités suggérées

Stratégie de communication

- Élaborer un plan de communication pour sensibiliser la population générale à la méningite et pour informer sur le comportement adéquat en matière de demande de diagnostic et de recours aux soins, d'identification des séquelles et de demande de soutien et de soins post-méningite.
- Élaborer une stratégie de communication visant à sensibiliser les responsables de tous les niveaux (par exemple, municipalité, district, province, central) au fardeau et aux conséquences de la méningite – notamment en matière d'économie, d'équité et de développement.

Campagnes (dans le cadre de la stratégie de communication)

- En collaboration étroite avec les organisations de la société civile et les communautés, préparer et mener des campagnes pour la Journée mondiale de la méningite (5 octobre), potentiellement en utilisant les documents mis à disposition par la Confederation of Meningitis Organizations (CoMO).
- En collaboration étroite avec les organisations de la société civile et les communautés, ainsi qu'avec les autres parties intéressées, rédiger des messages de sensibilisation à la méningite et sur la lutte contre cette maladie et les diffuser au cours d'autres campagnes annuelles, telles que la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre), la Semaine mondiale de la vaccination (dernière semaine d'avril), la Journée mondiale de lutte contre le sepsis (13 septembre), le GBS Awareness Month (juillet), la Journée internationale de l'épilepsie (deuxième lundi de février) et la Journée de sensibilisation à la surdité (dernière semaine de septembre).

Autres activités de communication (dans le cadre de la stratégie de communication)

- Identifier des porte-paroles qui pourraient défendre la sensibilisation à la méningite (par exemple, des célébrités ou des personnes ayant survécu à la maladie).
- Élaborer des stratégies de communication pour la sensibilisation et la mobilisation sociale afin de défendre l'efficacité, la sécurité et les avantages des vaccins.
- Assurer la liaison avec d'autres initiatives contribuant à des objectifs communs (par exemple, amélioration de l'accès au soutien et aux soins des personnes vivant avec un handicap, augmentation de la demande en vaccins).
- Mettre en place des communications régulières (par exemple, un bulletin d'information) avec un large éventail de parties prenantes pour améliorer et faire perdurer la sensibilisation au plan national de lutte contre la méningite, aux activités de ce plan et à ses réalisations.

Mobilisation des ressources

- Inventorier les parties prenantes/organisations susceptibles de fournir des ressources utiles à la lutte contre la méningite.
- Élaborer des plans avec les parties prenantes/organisations à même de fournir des ressources aux niveaux central, provincial et du district ou à un niveau quel qu'il soit.

Éléments potentiels à prendre en compte

- Quelles sont les cibles importantes des communications et quels messages doivent être transmis à chacune d'elles ? Ces cibles incluent les décideurs, les personnels de santé et la population générale.
- Y a-t-il des plans de communication existants qui peuvent être adaptés ? Ces plans ont-ils été évalués ?
- Comment augmenter la communication sur la méningite et encourager des changements de comportement tout au long de l'année, en dehors des journées spéciales, telles que la Journée mondiale de la méningite ?
- Que doit-on savoir ? Quelles sont les aspirations des personnes ?
- Quelles sont les principales mésinformations et d'où proviennent-elles ? Comment peut-on lutter contre la mésinformation ?
- Comment la sensibilisation touchera-t-elle les populations les plus vulnérables ?
- Qui peut soutenir les efforts de sensibilisation ? Des célébrités nationales ou locales ? Existe-t-il des membres de la communauté ayant un vécu de la maladie qui peuvent partager leur histoire ?
- Comment les campagnes de sensibilisation à la méningite peuvent-elles être intégrées dans des communications plus larges sur la santé ?
- Comment utiliser les campagnes de sensibilisation à la méningite pour faire passer d'autres messages importants sur la santé ?
- Comment les personnels de santé – en particulier au niveau communautaire – peuvent-ils être davantage sensibilisés à la méningite pour accélérer le diagnostic et le traitement ?
- Quel est le rôle des différents niveaux de services de santé et personnels de santé dans la sensibilisation à la méningite ?
- Quel peut être le rôle des secteurs autres que la santé – notamment des secteurs éducatifs – dans la sensibilisation à la méningite ?
- Quels types de ressources peuvent être utiles pour concourir à la mise en œuvre du plan et sensibiliser à la méningite ? Des ressources financières ? Des médias et forums de communication ? Le soutien de célébrités ? Autre ?
- Envisager différentes catégories de contribution et à différents niveaux. Nombre d'entre eux peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à appuyer la mise en œuvre du plan.
- Comment peut-on obtenir l'engagement de la société civile à mobiliser des ressources pour vaincre la méningite ?

Autre(s) domaine(s) pertinent(s) pour le pays

5. Mécanismes de déploiement

Comment faciliter la mise en œuvre effective des activités ?

5.1 Leadership, coordination et synergies

Une structure de gouvernance performante est essentielle pour une mise en œuvre effective et efficace du plan national. Cela sera indispensable pour favoriser la mise en œuvre et générer un fort impact pour les communautés.

Les éléments suivants peuvent être pris en compte pour décrire comment le plan sera coordonné et comment les parties prenantes s'engageront activement à établir des mécanismes de gouvernance et de coordination.

1. Le **Ministre de la santé peut désigner une coordonnatrice ou un coordonnateur national, avec un mandat bien défini.** La coordonnatrice ou le coordonnateur doit réserver une partie de son temps au plan de lutte contre la méningite. Selon les ressources disponibles, la coordonnatrice ou le coordonnateur peut soit occuper un poste spécifique (à temps partiel ou à temps plein) pour cette fonction, soit un poste existant dont une partie du temps sera consacrée spécifiquement à la coordination du plan.
2. Conformément au processus d'élaboration du plan (voir la section *Une démarche nationale* ci dessus), **un groupe restreint incluant les principales parties prenantes dans la lutte contre la méningite** peut appuyer l'action de la coordonnatrice ou du coordonnateur et assurer la liaison avec les parties prenantes nationales.
3. Pendant la phase de mise en œuvre, il est primordial de **maintenir l'engagement de toutes les parties intéressées.** Ces partenariats et collaborations doivent être renforcés. À cette fin, un suivi doit être prévu à intervalles réguliers, en particulier – mais pas uniquement – avec :
 - les autres programmes et initiatives susceptibles de concourir à la concrétisation du plan ;

- les acteurs non traditionnels de la lutte contre la méningite, notamment dans les secteurs autres que celui de la santé ;
 - les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes, conformément au pilier 5.
4. L'une des clefs du succès consiste à créer un **forum pour échanger des idées et des pratiques exemplaires, discuter des progrès accomplis et des difficultés rencontrées, et générer des commentaires qui permettront d'ajuster le plan et d'améliorer sa mise en œuvre.**
 - Des réunions rassemblant les principaux exécutants doivent être prévues à intervalles réguliers (par exemple, une fois par mois) pour effectuer le suivi de la mise en œuvre et en discuter.
 - Des réunions plus larges (dont la fréquence reste à déterminer) peuvent être organisées pour assurer la liaison avec un groupe plus étendu de responsables de la mise en œuvre et de parties prenantes.
 - En dehors des réunions régulières, s'il y a lieu, des canaux de communication peuvent être créés avec les principales parties prenantes (telles que le groupe restreint) à différents niveaux, par exemple en utilisant les médias sociaux ou des groupes de communication.
 - Si nécessaire, des groupes de travail peuvent également être créés pour aborder des thèmes spécifiques et contribuer ainsi à faire progresser des activités précises.
 5. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan et les difficultés rencontrées doivent être notifiés au plus haut niveau (Ministre de la santé).
 6. Le plan en cours d'élaboration sera ajusté ultérieurement en fonction des réalisations, des difficultés rencontrées et de la mise à disposition de nouveaux produits (voir aussi la section Suivi et évaluation ci-dessous). Dans ce cadre, la fréquence de mise à jour peut être un sujet de réflexion.

5.2 Budgétisation et financement

Des ressources sont nécessaires pour la mise en œuvre des activités du plan.

1. Le budget du plan doit être établi. Étant donné que certaines activités ont déjà été mises en œuvre et peuvent faire l'objet d'un financement régulier (même s'il est insuffisant), il est important d'**identifier précisément les ressources supplémentaires requises pour renforcer les activités et en exécuter de nouvelles**. En d'autres termes, la compréhension et la consolidation des niveaux de ressources actuels permettent d'identifier des lacunes. Le panier de services de la CSU peut s'avérer utile pour réfléchir aux ressources (et à leurs coûts) requises pour la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins post-hospitalisation de la méningite.
2. Il peut s'avérer difficile de mobiliser toutes les ressources supplémentaires nécessaires en même temps. **Les domaines prioritaires pour la mobilisation de ces ressources peuvent être établis.**
3. Il ne serait en réalité pas judicieux d'attendre que toutes les ressources soient mises à disposition pour commencer à mettre en œuvre le plan. **Si des ressources manquent pour commencer simultanément toutes les activités, une approche par étapes peut être adoptée ; les activités prioritaires, et celles pour lesquelles des ressources peuvent facilement être mobilisées doivent commencer en premier.** Une mise en œuvre réussie des premières activités facilitera la mobilisation durable des ressources.
4. On tâchera de **rendre la mise en œuvre et le financement transversal les plus efficaces possibles**, mais certaines ressources disponibles pourraient ne pas être identifiées de prime abord. Compte tenu de la nature pluridisciplinaire de la feuille de route, **il pourrait être possible de tirer parti de ressources techniques, humaines, en nature et financières qui n'ont pas été affectées directement à la lutte contre la méningite**, mais qui sont disponibles par l'entremise d'autres programmes ou initiatives. Ces ressources peuvent contribuer de manière directe ou indirecte à la mise en œuvre du plan de lutte contre la méningite, qui, à son tour, par les synergies exposées dans le présent document, peut générer des conditions propices à une utilisation plus efficiente de ces ressources.
5. Les ressources supplémentaires visant à renforcer les activités existantes ou à en exécuter de nouvelles peuvent notamment provenir **de fonds publics nationaux, d'autres sources nationales** (par exemple, organisations philanthropiques nationales) **et de contributeurs externes** (par exemple, une branche locale d'une ONG internationale ou une organisation philanthropique internationale). Pour garantir que les ressources nécessaires pour lutter durablement contre la méningite seront disponibles, les activités ne devront pas être mises en œuvre de manière isolée.
6. Les pays doivent prendre la tête des efforts de mobilisation des ressources. En effet, bien que des partenaires internationaux puissent s'être engagés à soutenir une partie des efforts, il n'existe aucune enveloppe mondiale destinée à l'appui des financements nationaux.

5.3 Logistique et chaîne d'approvisionnement

La sélection, l'achat et la constitution de stocks de vaccins, produits de diagnostic, dispositifs médicaux, médicaments et technologies d'assistance sont des éléments essentiels d'un plan national exhaustif de lutte contre la méningite. Pour mettre en œuvre efficacement ces activités, plusieurs principes essentiels de logistique et chaîne d'approvisionnement sont exposés et résumés ci-dessous.

Principes essentiels des opérations de logistique et de chaîne d'approvisionnement

1. Collaborer avec les principales parties prenantes et les principaux partenaires

- Collaborer étroitement avec les parties prenantes à la vaccination, au diagnostic, au traitement et à la prise en charge des séquelles afin d'estimer les besoins en fournitures et d'évaluer les ressources et systèmes d'approvisionnement disponibles.
- Actualiser et inventorier régulièrement les ressources existantes à tous les niveaux de soins.

2. Créer des mécanismes de recueil d'informations

- Mettre au point des systèmes permettant de recueillir des données pertinentes sur les indicateurs clefs de performance, les avancées au diagnostic, les déficits d'approvisionnement et les possibilités d'optimisation.
- Effectuer un suivi de l'efficacité des processus, des taux de consommation, des taux de perte et de l'accès aux marchés locaux pour identifier les éléments à améliorer.

3. Mettre en œuvre des systèmes de contrôle et de gestion de la chaîne d'approvisionnement ou les optimiser

- Prendre des dispositions pérennes de constitution des stocks, stockage, sécurité, transport et distribution des fournitures médicales et essentielles.
- Améliorer les processus d'assurance de la qualité si nécessaire.

4. Soutenir les efforts nationaux de livraison et de distribution

- Simplifier l'aménagement logistique de bout en bout pour la livraison et la distribution des fournitures, notamment des vaccins, produits de diagnostic, dispositifs médicaux, médicaments et technologies d'assistance.
- Mobiliser les partenaires et coordonner la circulation organisée des fournitures vers les établissements de santé et les autres lieux concernés.

5. Mettre en œuvre une stratégie de test nationale ou optimiser son fonctionnement

- **Créer des mécanismes performants** et des filières bien définies pour la circulation et le transport des échantillons dans les établissements de santé au niveau du district, de la province/région et du pays.

6. Coordonner l'appui logistique pour les communautés difficiles d'accès

- Collaborer avec les principaux partenaires afin de garantir une capacité technique suffisante pour apporter un appui logistique à la livraison de fournitures, de matériel et de services dans les zones éloignées et mal desservies.
- Aborder les défis spécifiques au contexte pour atteindre efficacement ces communautés.

7. Intégrer des mesures de préparation et riposte aux flambées épidémiques dans le plan (dans les zones à potentiel épidémique)

- Anticiper l'intensification des besoins en fournitures médicales à l'aide d'une projection des augmentations potentielles en situation d'épidémie et en garantissant un appui opérationnel et logistique aux niveaux national et infranational.
- Créer des mécanismes solides permettant de mobiliser les fournitures depuis les lieux de stockage dans les délais opportuns pour les acheminer vers les points d'utilisation pendant la riposte aux épidémies.
- Mettre en œuvre des mécanismes de suivi pour garder la trace de la disponibilité, des conditions de stockage et de la logistique de transport afin de préserver la qualité et l'accessibilité des fournitures.

Il est primordial d'adapter et d'ajuster ces activités au contexte et en fonction des ressources disponibles. Une évaluation et une amélioration continues de la gestion de la chaîne d'approvisionnement contribuent largement à assurer la mise en œuvre réussie du plan.

5.4 Suivi et évaluation

Il est important d'effectuer un suivi et une évaluation de la mise en œuvre effective du plan, sans omettre ses effets, afin d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées et de l'ajuster selon les besoins. Une fois les objectifs et activités du plan de lutte contre la méningite définis, un plan de suivi et d'évaluation (S&E) peut être élaboré pour le suivi de sa mise en œuvre et de ses effets.

Sur quelle base doivent s'effectuer le suivi et l'évaluation du plan ?

1. Le suivi peut s'effectuer sur plusieurs niveaux au moyen d'indicateurs spécifiques :
 - Indicateurs de produits, pour mesurer la réalisation des activités planifiées.

- Indicateurs de résultats, pour mesurer les effets à court et moyen termes d'une intervention.
 - Indicateurs d'impact, pour mesurer l'effet cumulé à long terme des programmes ou interventions au fil du temps sur leurs objectifs ultimes, comme une modification de la morbidité et de la mortalité liées à la méningite.
 - Des indicateurs de processus visant à évaluer le processus de mise en œuvre et d'intégration (tel que la fréquence des réunions de coordination) peuvent être ajoutés.
2. Les indicateurs de produits doivent être en phase avec les activités du plan. Le suivi de la mise en œuvre doit reposer sur une définition claire d'objectifs et d'activités limités dans le temps et quantifiés. L'annexe 2b fournit un exemple de modèle pour faciliter le suivi de la mise en œuvre.
 3. Au niveau international, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route reposent sur divers indicateurs de produits, de résultats et d'impact – ainsi que sur le suivi de la réalisation/réussite des étapes principales de la feuille de route. Dix de ces indicateurs sont qualifiés d'indicateurs de base, en effet : i) ils reflètent une facette importante de la riposte à la méningite qui générera des informations pertinentes pour la prise en charge de la maladie au niveau national ou mondial ; ii) ils sont suffisamment sensibles pour détecter un changement ; iii) ils sont mesurables dans les pays pendant la période de mise en œuvre de dix ans. Les pays sont encouragés à recueillir des données sur les indicateurs de base.

Le Tableau 1 propose divers indicateurs à collecter pour faciliter le suivi et l'évaluation au niveau international.

Tableau 1 Propositions d'indicateurs nationaux pour le suivi et l'évaluation inspirés des indicateurs internationaux

Code d'indicateur mondial	Indicateur		Observations
	Au niveau mondial	Au niveau national	
Impact 2	Incidence des cas de méningite à Nm, Spn, Hib et aux SGB (au niveau mondial) pour 100 000 habitants	Données de surveillance épidémiologique des cas signalés de méningite à Nm, Spn, Hib et SGB	Estimé au niveau mondial à partir des données de surveillance épidémiologique complétées par des modèles statistiques. Les données nationales viennent enrichir l'estimation.
Impact 3	Taux de mortalité liée à la méningite à Nm, Spn, Hib et aux SGB (au niveau mondial) pour 100 000 habitants	Données de surveillance épidémiologique des décès dus à la méningite à Nm, Spn, Hib et SGB	Estimé au niveau mondial à partir des données de surveillance épidémiologique complétées par des modèles statistiques. Les données nationales viennent enrichir l'estimation.
Résultat 1	Taux de couverture des vaccins anti-Spn, anti-Hib et anti-Nm multivalents dans les groupes ciblés par la vaccination, ainsi que du vaccin anti-SGB lorsqu'il est disponible	Couverture vaccinale du VPC (toutes les doses), du vaccin anti-Hib (DCT3), du vaccin anti-Nm et du vaccin anti-SGB (femmes enceintes – lorsqu'il est disponible)	Associe différentes sources : couverture par la vaccination systématique, les campagnes de prévention et les campagnes d'intervention d'urgence supervisées par l'OMS.
Produit 1.1	Pourcentage de pays ayant mis en œuvre des programmes de vaccination systématique conformes aux lignes directrices nationales contre Nm, Spn et Hib, et contre les SGB lorsque le vaccin est disponible	Présence et mise en œuvre effective de la vaccination dans le programme de vaccination national contre Spn, Hib, Nm et les SGB	Nm : cible les enfants et/ou les adolescents. SGB : cible les femmes enceintes.
Résultat 2	Pourcentage de pays ayant prélevé des échantillons de liquide céphalorachidien (ou de sang) chez au moins 50 % des cas suspects de méningite	Pourcentage d'échantillons de liquide céphalorachidien (ou de sang) prélevés chez les cas suspects de méningite	

Continued

Produit 3.1	Pourcentage de pays envoyant des échantillons et les données épidémiologiques connexes pour au moins X % (pourcentage cible défini par région) des cas confirmés de méningite au réseau mondial en vue de la surveillance moléculaire de Nm, Spn, Hib et des SGB	Pourcentage d'échantillons prélevés envoyés à un réseau régional ou mondial en vue de la surveillance moléculaire de Nm, Spn, Hib et des SGB	Peut être complété par le nombre d'échantillons.
Résultat 4	Pourcentage de personnes affectées par la méningite qui ont reçu des soins et un soutien pour la prise en charge des séquelles	Nombre de personnes affectées par la méningite qui ont reçu des soins et un soutien pour la prise en charge des séquelles	Données qualitatives supplémentaires.
Produit 4.2	Pourcentage de pays disposant de programmes à assise communautaire pour apporter un soutien aux personnes affectées par la méningite	Disponibilité de programmes à assise communautaire	Préciser si les programmes sont disponibles dans le pays entier ou dans des zones particulières.
Produit 5.2	Pourcentage de pays ayant mené des campagnes de sensibilisation adaptées au fardeau national et intégrées dans les activités de sensibilisation sanitaire existantes	Nombre de campagnes de sensibilisation à la méningite menées pendant le cycle de mise en œuvre	La liste des campagnes et des activités de sensibilisation peut être dressée.

Quel doit être le processus de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du plan ?

Le plan S&E doit définir :

- la fréquence de recueil et d'analyse des données ;
- les personnes responsables du recueil, de l'analyse et de la présentation des données ;

- si une évaluation plus approfondie, par exemple en tenant compte de facettes supplémentaires et par des entretiens avec les parties prenantes, est nécessaire ;
- les personnes chargées d'examiner les résultats de l'analyse et d'exécuter des mesures permettant d'ajuster le plan en conséquence.

Annexe 1. Les parties prenantes

Liste non exhaustive des parties prenantes et de leur rôle potentiel dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan national de lutte contre la méningite*

Ministère de la santé	Coordonner, préconiser et faciliter la contribution d'autres ministères, organismes publics et parties prenantes ; diriger et faciliter l'élaboration des plans et programmes nationaux.
Divisions administratives infranationales	Fournir un appui à la mise en œuvre de certaines activités au niveau administratif (par exemple, province, district, municipalité), notamment en pilotant certaines activités avant leur transposition à plus grande échelle. Des fonds spécifiques peuvent être accordés et gérés directement à ce niveau.
Personnels de santé	Préconiser des mesures, fournir des informations cliniques et de santé publique et apporter un soutien aux politiques et aux processus de planification ; fournir un appui pour la mise en œuvre des plans et des programmes.
Établissements d'enseignement	Fournir des conseils d'expert pour les stratégies de lutte ainsi que pour le suivi et l'évaluation.
Associations scientifiques et professionnelles	Participer à l'élaboration et/ou à l'adaptation et/ou à la diffusion des lignes directrices nationales pour sensibiliser aux activités en rapport avec la méningite et augmenter les connaissances à ce sujet.
ONG (du niveau local au niveau mondial)	Préconiser des mesures de lutte contre la méningite, mobiliser le soutien communautaire et organiser des campagnes d'information et d'éducation. Apporter des soins, un soutien et des services spécifiques.
Société civile	Sensibiliser le public et les politiques à la méningite, augmenter les fonds alloués à la recherche et améliorer la transparence dans les secteurs public et privé.
Médias	Fournir une veille permanente des campagnes de sensibilisation dans les médias pour mieux faire connaître la maladie et encourager les débats ; les journalistes peuvent jouer un rôle clef dans la sensibilisation et l'éducation du public à la lutte contre la méningite.

Continued

Organisations caritatives et philanthropiques nationales (ou constituant des branches d'organisations internationales)

Apporter un soutien financier à la mise en œuvre d'activités spécifiques.

Secteur privé (laboratoires pharmaceutiques et fabricants de produits de diagnostic)

Mettre au point et fabriquer des produits abordables et de haute qualité. Apporter des contributions en nature ou prendre d'autres dispositions spéciales pour l'approvisionnement en vaccins, produits de diagnostic et traitements.

Ministère de l'éducation

Élaborer des politiques de santé et des programmes sanitaires au sein des établissements scolaires. Repérer les enfants vivant avec des troubles cognitifs mineurs ou d'autres handicaps provoqués par la méningite. Soutenir l'inclusion des enfants vivant avec un handicap.

Ministère des finances

Veiller à ce que des ressources financières soient disponibles pour soutenir la mise en œuvre du plan national. Contribuer à l'identification des fonds nationaux et/ou étrangers pour renforcer la mise en œuvre du plan de lutte contre la méningite.

Ministère du travail/ de l'emploi

Veiller à l'adoption de lois du travail encourageant les mesures de santé publique en faveur de modes de vie sains sur les lieux de travail. Encourager l'emploi des personnes vivant avec un handicap.

Ministère des affaires étrangères

Négocier, analyser et garantir l'adoption de cadres et d'accords internationaux normatifs en lien direct avec les questions de santé publique.

Annexe 2a : Vue d'ensemble d'une proposition de modèle (prêt à l'emploi) – exemple du pilier 2

Le modèle est disponible ici : <https://www.who.int/publications/m/item/template-for-national-meningitis-plan>

Diagnostic et traitement (pilier 2)

Contexte

[Décrivez le contexte, la pertinence du pilier au regard des circonstances nationales, la situation actuelle, les défis à relever, l'approche et les perspectives générales, etc.]

Objectifs en matière de diagnostic et de traitement :

- Objectif 1
- Objectif 2, etc.

Stratégie nationale de test

Activités y acciones específicas	Calendrier	Entité responsable	Autres (observations, etc.)
• Activité 1			
◦ Action spécifique 1 (selon les besoins)			
◦ Action spécifique 2 (selon les besoins)			
• Activité 2			
◦ Action spécifique 1 (selon les besoins)			
◦ Action spécifique 2 (selon les besoins)			
• Activité 3			
◦ Action spécifique 1 (selon les besoins)			

Diagnostic

Activités et actions spécifiques	Calendrier	Entité responsable	Autres (observations, etc.)
•			
•			

Annexe 2b : Exemple – matrice de suivi de la mise en œuvre d’une activité

ACTIVITÉ ¿Cuál es la actividad a implementar ?	MESURES SPÉCIFIQUES Quelles mesures doivent être réalisées pour mettre en œuvre l’activité ?	responsable Qui est chargé de la mesure ?	CALENDRIER Quand la mesure doit-elle être achevée ?	ÉTAT D’AVANCEMENT Est-ce que la mesure n’a pas encore commencé, est en cours ou est achevée ? <i>Rouge/orange/vert</i>
EXEMPLE Améliorer le prélèvement et le test des échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) dans trois hôpitaux du district X	• Former le personnel sur les indications cliniques et la méthode de prélèvement	• Responsables régionaux de la formation médicale	• Juin 2023	• En cours
	• Bilan du matériel et des réactifs de laboratoire pour le traitement des échantillons de LCR	• Responsables de laboratoire dans chaque hôpital	• Septembre 2022	• Achevé
	• Notification mensuelle du nombre de cas suspects et du nombre d’échantillons	• Responsables cliniques – maladies infectieuses • Responsables de laboratoire – surveillance	• Suivi permanent • Mars – septembre 2023	• Mise en place de la surveillance, en cours dans les hôpitaux 1 et 2, en attente dans l’hôpital 3

Annexe 3 : Documentation

1. Contrôle des épidémies de méningite en Afrique : guide de référence rapide à l'intention des autorités sanitaires et des soignants. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2015 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/154595>).
2. Meningitis outbreak response in sub-Saharan Africa: WHO guideline. Geneva: World Health Organization; 2014 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/144727>).
3. Procédures opérationnelles standard pour la surveillance, la préparation et la riposte aux épidémies de méningite en Afrique. Genève : Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique ; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/312141>).
4. Meningitis. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/health-topics/meningitis#tab=tab_3).
4. WHO Vaccine Papers on pneumococcal vaccines. Geneva: World Health Organization; 2019, 2021 (<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/position-papers/pneumococcus>).
5. WHO: Haemophilus influenzae type b (Hib) Vaccination Position Paper. Geneva: World Health Organization; 2013 (<https://www.who.int/publications/i/item/who-wer8839-413-426>).
6. WHO Vaccination campaigns – routine, catch-up, emergency. Geneva: World Health Organization (<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/essential-programme-on-immunization/implementation/immunization-campaigns>).
7. International Coordinating Group (ICG) on vaccine provision – meningitis. Geneva: World Health Organization (<https://www.who.int/groups/icg/meningitis/stockpiles>).
8. Guide d'introduction du vaccin conjugué contre le méningocoque A dans le programme de vaccination systématique. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241516860>).

Prévention et lutte contre les épidémies

1. Immunization Agenda 2030 strategy and implementation plan. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030>).
2. Recommandations de l'OMS sur la vaccination systématique. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2023 (<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/who-recommendations-for-routine-immunization---summary-tables>).
3. WHO Position Papers on meningococcal vaccines. Geneva: World Health Organization; 2011, 2015, 2024 (<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/policies/position-papers/meningococcal-vaccines>).

Diagnostic et traitement

1. Specifications for rapid diagnostic testing, Africa meningitis belt. Geneva: World Health Organization (<https://www.who.int/publications/m/item/specifications-for-a-rapid-diagnostic-test-for-meningitis-african-meningitis-belt>).
2. Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de l'enfance, 2e éd. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2015 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/81170>).

3. The WHO AWaRe (access, watch, reserve) antibiotic book. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/365237>).
4. Model List of Essential Medicines. Geneva: World Health Organization (<https://www.who.int/groups/expert-committee-on-selection-and-use-of-essential-medicines/essential-medicines-lists>).
6. Signalement précoce, alerte et riposte dans les situations d'urgence : guide opérationnel. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2024 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/365730>).

Surveillance des maladies

1. Méningocoque : Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (<https://www.who.int/publications/m/item/vaccine-preventable-diseases-surveillance-standards-meningococcus>).
2. Pneumocoque : Normes de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018 (<https://www.who.int/publications/m/item/vaccine-preventable-diseases-surveillance-standards-pneumococcus>).
3. Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte dans la région Africaine. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (<https://www.afro.who.int/publications/technical-guidelines-integrated-disease-surveillance-and-response-african-region-third>).
4. Boîtes à outils de l'OMS pour les données de santé numérique. Genève : Organisation mondiale de la Santé (<https://docs.dhis2.org/en/topics/metadata/dhis2-who-digital-health-data-toolkit/about-the-who-digital-health-data-toolkit.html>).
5. Systèmes nationaux de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et participation au Système mondial de surveillance de cette résistance (GLASS) — Guide de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2016 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-DGO-AMR-2016.4>).

Séquelles et soins post-hospitalisation

1. ATLAS Country resources for neurological disorders. Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://www.who.int/publications/i/item/atlas-country-resources-for-neurological-disorders>).
2. Draft intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders 2022–2031. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/news/item/28-04-2022-draft-intersectoral-global-action-plan-on-epilepsy-and-other-neurological-disorders-2022-2031>).
3. Rehabilitation 2030: A call for action. Geneva: World Health Organization (<https://www.who.int/initiatives/rehabilitation-2030>).
4. Rapport mondial sur la vision. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2019 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570>).
5. World report on hearing. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing>).

Sensibilisation et mobilisation

1. Meningitis Research Foundation. Bristol: Meningitis Research Foundation (www.meningitis.org/).
2. Confederation of Meningitis Organizations. Bristol: Meningitis Research Foundation (<https://www.comeningitis.org/>).

Organisation mondiale de la Santé

Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27
Switzerland

Email: meningitis2030@who.int

Website: <https://www.who.int/initiatives/defeating-meningitis-by-2030>